DON01_A04_V50 Hatályos: 2026.04.07.

A véradásra való alkalmasság feltételei

Szakmai jóváhagyás:	Minőségbiztosítási jóváhagyás:
dr. Nagy Sándor	dr. Baróti-Tóth Klára
szakmai főigazgató-helyettes sk.	minőségbiztosítási igazgató sk.

Készítő munkacsoport: dr. Baróti-Tóth Klára, dr. Csépány Norbert, Csernus-Lukács Brigitta, Farkas Olga, dr. Jenei Béla, dr. Lázár Mária, dr. Pászthy Vera, dr. Molnár Katalin, dr. Nagy Sándor, dr. Tóth Anikó

1. A dokumentum változásainak nyilvántartása

	Dátum	Szakasz	Változtatás leírása	Elrendelte
V48	**2026.01.01**	fogalom meghatározások	a „kiszűrés visszavonás” fogalmának újra definiálása	dr. Nagy Sándor
		RF02 RF25 RF37	kompetencia szint változik	dr. Nagy Sándor
		FB47 FC47 FW47 FH47	módosíthatóság változik	dr. Nagy Sándor
		BF02 BF03 BU03 FK04	módosíthatóság változik	dr. Nagy Sándor
		BK13 BK14 BG01 FK05	módosíthatóság változik	dr. Nagy Sándor
		RF07 RF38 RF39 RF40	módosíthatóság változik	dr. Nagy Sándor
		RF41 RF08 RF37 RF23	módosíthatóság változik	dr. Nagy Sándor
		RF27 RF34 RA12	módosíthatóság változik	dr. Nagy Sándor
		XX10	új kiszűrés (inf. rendezés alatt)	dr. Nagy Sándor
		RA27	új kiszűrés (Bact Allert alarm)	dr. Nagy Sándor
		RF31	visszaállítás (ABO ism. diszkr.)	dr. Nagy Sándor
		RF32	pontosítás	dr. Nagy Sándor
		RF10	dermaroller	dr. Nagy Sándor
		RF37	szöveg pontosítás	dr. Nagy Sándor
		FY14	pontosítás	dr. Nagy Sándor
V49	**2026.02.01**	RA28	új kiszűrés k.m.n. PDI re	dr. Nagy Sándor
		XX10	szabály pontosítása	dr. Nagy Sándor
		RA27	kompetencia szint módosult	dr. Nagy Sándor
V50	**jelen kiadás**	valamennyi kód	bekerülnek a kiszűrésekhez tartozó tájékoztató levelek kódjai	dr. Nagy Sándor
		XX06	eredmény megjegyzése változik	dr. Nagy Sándor
		RA09	hipotenzív szövődmény utólagos rögzítése	dr. Nagy Sándor
		RA24	INAKTÍV (Helyette NKDR jelentés alapján „U”)	dr. Nagy Sándor

2. Műveleti szabályok:

DON01 utasítás

A KISZŰRÉSEK TÍPUSAI és TULAJDONSÁGAI

Átmeneti kiszűrés:

Az ÁTMENETI kiszűrés az alapértelmezésben definiált **meghatározott időtartamú**.

A kiszűrés alapértelmezésben megadott időtartama a kompetencia szint- és a módosítási szabályok szerint rövidíthető vagy hosszabbítható.

Az alapértelmezett időtartam módosításának okát az orvosi megjegyzésben meg kell adni.

Tartós kiszűrés:

A TARTÓS kiszűrés alapértelmezés szerint **végtelen idejű**.

A kiszűrés alapértelmezésben megadott időtartama (99999 nap) a kompetencia szint- és a módosítási szabályok szerint rövidíthető.

Az időtartam rövidítésének okát az orvosi megjegyzésben meg kell adni.

Végleges kiszűrés:

A VÉGLEGES kiszűrés **végtelen idejű.**

A kiszűrés időtartama (99999 nap) nem változtatható.

A kiszűrések megszüntetésének (lezárásának illetve visszavonásának) jogosultsági szintjei*:*

magas kompetencia szint:	###	szakmai főigazgató-helyettes
közepes kompetencia szint:	##	konfirmáló laboratórium meghatalmazott diplomás / minőségbiztosítási igazgató
alacsony kompetencia szint:	#	kivizsgáló / vérellátó vezető

A kiszűrési időtartam módosíthatósága:

Ø: az alapértelmezett kiszűrési időtartam semmilyen kompetencia szinttel nem változtatható

↑: a megfelelő kompetencia szinttel rendelkező személy az alapértelmezett kiszűrési időtartamot növelheti

↓: a megfelelő kompetencia szinttel rendelkező személy az alapértelmezett kiszűrési időtartamot csökkentheti

↑↓: a megfelelő kompetencia szinttel rendelkező személy az alapértelmezett kiszűrési időtartamot növelheti és csökkentheti

A VÉRADÁS ENGEDÉLYEZÉSE, ILLETVE A KISZŰRÉSEK ELRENDELÉSE

A véradás engedélyezése illetve a kiszűrés elrendelése a véradás előtti kivizsgálás során:

A véradó alkalmasságának megállapításakor a kivizsgáló engedélyezi a véradást, vagy elrendeli a megfelelő kiszűrést.

A kiszűrés kezdő dátuma és időtartama:

A kiszűrés kezdő dátumaként azt az időpont kell megadni, amikor a kiszűrési ok keletkezett.

A kiszűrés kezdő időpontja a betegség diagnózisa vagy észlelése (lappangási idő nélkül), illetve a kockázatos magatartás, esemény megtörténtének időpontja. Tetoválás, kockázatos szexuális kapcsolat, visszatérés kockázatos epidemiológiai környezetből, vakcináció attenuált oltóanyaggal stb. esetében a kiszűrés az esemény napjával indul. Ha a véradó nem tudja felidézni a betegség megjelenésének, vagy a kockázati tényező keletkezésének pontos időpontját, de azt heti, havi vagy éves szinten meg tudja mondani, akkor a megadott időintervallum legkorábbi napjától kell indítani a kiszűrést (pl. a hónap első napja). Ha a véradó egyáltalán nem tudja felidézni a betegség megjelenésének, vagy a kockázati tényező keletkezésének időpontját, végső esetben a kiszűrést a kivizsgálás időpontjától (aktuális dátum) kell indítani.

*A **kivizsgálás napján indított kiszűrést lehetőleg kerülni kell** tetoválás, endoszkópos beavatkozás, akupunktúra és testékszer felhelyezés esetén, mert ezekben az esetekben a plazmafrakcionáló felé nehezített eljárásrend szerint kell tovább jelenteni!*

Amennyiben a kivizsgáló nem tesz megjegyzést a véradó bizonylaton, a kiszűrés az alapértelmezés szerinti időtartamra történik.

Utólagos bejelentésen (PDI) alapuló kiszűrés elrendelése:

Lásd: VIR01_ELJ

Kivizsgálási eredményként keletkező kiszűrés:

A véradó vércsoport-szerológia vagy fertőzőbetegség vizsgálata során a kiszűrések automatikusan kerülnek a véradóra.

KISZŰRÉSEK MEGSZÜNTETÉSE

Az ÁTMENETI kiszűréseket –a záró dátum napján– az eProgesa rendszer automatikusan lezárja.

A fennálló kiszűrés manuális megszüntetése két, egymással fel nem cserélhető módon történhet:

- a kiszűrés lezárásával (a kiszűrés záró dátumának rövidítésével),
- a kiszűrés visszavonásával (*e*Progesa „VISSZAVONÁS” gombbal).

KISZŰRÉSEK FENNTARTÁSA, RÖVIDÍTÉSE, ILLETVE LEZÁRÁSA

A véradásra jelentkező kiszűrt véradókat „§” vérvételi típussal kell felvenni az eProgesa rendszerbe.

Az adminisztratív ok miatt alkalmatlan jelentkezőket „U” vérvételi típussal kell felvenni.

A bizonylatot a kérdőív hátoldalára kell nyomtatni, és az adategyeztetést követően a nyilatkozat és a kérdőív kitöltése nélkül, a véradót közvetlenül a kivizsgálóhoz kell irányítani.

*A véradó eProgesa személyi lapján **a lezárt kiszűrés kódja-, megnevezése-, kezdő- és záró dátuma megmarad**.*

Amennyiben szükséges, a kivizsgáló a fennálló kiszűrés megszüntetésével együtt, egy más, releváns kiszűrési kód alkalmazásával fenntarthatja a véradó kiszűrését.

A kiszűrés fenntartása:

A mennyiben a „§” vérvételi típussal jelentkező véradó fennálló kiszűrésének lezárási feltételei nem teljesülnek, a kiszűrést a kivizsgálónak fenn kell tartani.

Alacsony kompetencia szintű (#) kiszűrés rövidítése a kivizsgálás során:

Amennyiben olyan, betegségből gyógyult (újra egészséges) személy jelentkezik véradásra, akinél a gyógyulást követő biztonsági kizárást a szabályok szerint még egy meghatározott ideig fenn kell tartani (pl. influenza, hasmenés, nemi betegség stb.), akkor a kivizsgálónak lehetősége van a kiszűrés (alapértelmezett) időtartamát rövidíteni. A rövidítés feltétele, hogy az alapértelmezett kiszűrés időtartam alacsony kompetencia szint (#) mellett rövidíthető (↓ vagy ↑↓) legyen.

A rövidített időtartam eltelte után a kiszűrés automatikusan lezáródik.

Az időtartam módosításának okát az orvosi megjegyzésben meg kell adni.

Amennyiben a kiszűrés lezárásának feltétele igazoló dokumentum bemutatása, akkor azt lehetőség szerint szkennelve csatolni kell a véradó személyi lapjához, vagy ha a szkennelés nem lehetséges, akkor a kivizsgálónak az orvosi megjegyzésben rögzítenie kell, hogy a donor a leletet bemutatta. A lelet azonosító adatait rögzíteni kell.

A kiszűrés fenntartása esetén a véradót tájékoztatni kell, és alá kell vele íratni a véradó bizonylatot.

Alacsony kompetencia szintű kiszűrés (#) lezárása a kivizsgálás során:

Amennyiben olyan személy jelentkezik véradásra akinél a kiszűrés lezárásának a feltételei teljesülnek, a kivizsgáló a kiszűrést úgy zárhatja le, hogy a kiszűrés záró dátumának az adott napot megelőző nap dátumát adja meg. A lezárás feltétele, hogy az alapértelmezett kiszűrés időtartam alacsony kompetencia szint (#) mellett rövidíthető (↓ vagy ↑↓) legyen.

Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az alacsony kompetencia szintű fennálló kiszűrés nyilvánvalóan téves.

A lezárás indokát rögzíteni kell az orvosi megjegyzések rovatban. Amennyiben a kiszűrés lezárásának feltétele igazoló dokumentum bemutatása, akkor azt lehetőség szerint szkennelve csatolni kell a véradó személyi lapjához, vagy ha a szkennelés nem lehetséges, akkor a kivizsgálónak az orvosi megjegyzésben rögzítenie kell, hogy a donor a leletet bemutatta. A leletazonosító adatait rögzíteni kell.

Ha a véradó a kiszűrés lezárásával egy időben vért szeretne adni, a kivizsgálónak az alábbiak szerint kell eljárnia:

1.) fel kell írnia a bizonylatra azt a vérvételi típust („V”; „P”; „T”), amelyre a véradó jelentkezik, ezután;

2.) a véradóval ki kell töltetni a nyilatkozatot, és a kivizsgálónak a kikérdezés során, a véradóval közösen ki kell töltenie a kérdőívet, ezután;

3.) a helyi sajátságok figyelembevételével el kell végezni a hemoglobin szint mérését, ezután;

4.) a kiszűrés záró dátumát az adott napot megelőző nap dátumára kell módosítania, ezután;

5.) az *e*Progesa rendszerben meg kell változtatnia a vérvételi típust („V”-re; „P”-re vagy „T”-re), és ezután;

6.) rögzíteni kell az orvosi vizsgálatot, ezután;

7.) OPCIONÁLIS: ha a kikérdezés vagy Hgb-mérés során új kizáró szempont kerül elő akkor rögzíteni kell az új kiszűrési kódot.

A vérvételt csak akkor szabad elvégezni, ha az eProgesa rendszer engedélyezi a vér vételét.

Közepes (##) és magas (###) kompetencia szintű kiszűrés központi lezárása:

Amennyiben a kiszűrés lezárásának feltételei teljesülnek, a kiszűrés időtartama rövidíthető (↓ vagy ↑↓) de a kompetencia szintje közepes (##) vagy magas (###) akkor a kivizsgálónak a véradó kiszűrését fenn kell tartania.

Ha a vérgyűjtési helyszínen lehetőség van a kiszűrés lezárásához szükséges lelet szkennelésére, vagy a leletet a véradó fénymásolva átadja, akkor a leletet a véradó személyi lapjához kell rögzíteni, és „Kiszűrés megszüntetését kérő lapon” (DON07_A08) az MBI-től kell kérni a kiszűrés lezárását.

A kivizsgálónak a véradó bizonylatra, és az orvosi megjegyzésbe rögzítenie kell, hogy kezdeményezte a kiszűrés központi lezárását.

A véradót tájékoztatni kell arról, hogy az OVSzK-ból 15 napon belül az EESZT-be feltöltik a döntést tartalmazó levelet a kiszűrés lezárásáról vagy fenntartásáról.

Amennyiben a kiszűrés lezárásához szükséges lelet a vérgyűjtési helyszínen nem szkennelhető, akkor meg kell kérni a véradót, hogy:

A.) eredeti leletével a vérellátó telephelyén jelentkezzen, vagy

B.) a legközelebbi kiszállásos jelentkezésére hozza magával fénymásolatban a leletet, vagy

C.) kezdeményezze a kiszűrés visszavonását a leletek másolatának csatolásával az ovsz@ovsz.hu címre írt levélben.

Az eseményt követően a korábbi véradó bizonyaltot nem szükséges előkeresni (irattárból másolatot igényelni).

Nem szabad a ## / ### kiszűrés megszüntetési eljárást elindítani azzal, hogy a véradót arra kérik, hogy pótlólag küldje el a dokumentumokat!

Kiegészítés magas kompenetcia szintű kiszűrés (###) lezárásához:

Abban az esetben, ha a fennálló magas kompetencia szintű kiszűrés nyilvánvalóan téves, függetlenül annak módosíthatóságától (tehát Ø is), a megfelelő indoklással „Kiszűrés megszüntetését kérő lapon” (DON07_A08) az MBI-től kell kérni a kiszűrés lezárását.

Ha a kiszűrés HBsAg, HIV, HCV vagy anti-TP „csak szűrővizsgálati reaktivitás” miatt történt, és a kiszűrés legalább öt évvel a véradó jelentkezése előtt keletkezett (konfirmáltan negatív, szűrőteszt váltásig kizárt, fals szűrő reaktív esetek), a kivizsgáló a DON07_A08 nyomtatványon kezdeményezheti a véradó kiszűrésének lezárását.

Ebben az esetben a véradótól nem szabad automatikusan mintát venni.

A donort tájékoztatni kell arról, hogy a kiszűrés fenntartásáról, vagy lezárásáról illetve mintavétel elrendeléséről szóló döntést az MBI felölti az EESZT felületre.

Anti-HBc reaktivitás esetén a véradó nem visszavehető!

KISZŰRÉSEK VISSZAVONÁSA

Alacsony kompetencia szintű kiszűrés (#) visszavonása <u>a vérvétel adminisztrálása során</u>:

Amennyiben alacsony kompetencia szintű (#) kiszűrés került tévesen a véradóra az orvosi kérdőív hibás kitöltése vagy adatrögzítési hiba miatt, akkor a <u>kiszűrés rögzítése visszavonható</u> annak érdekében, hogy az esemény hozzáférhető legyen.

Amennyiben kiszűrés visszavonásra került, a véradóhoz tartozó megjegyzés rovatban rögzíteni kell, hogy a visszavonás *„téves adatbevitel javítása”* miatt történt.

Tévesen rögzített kiszűrés visszavonása esetén a véradóhoz rendelt kiszűrés újra definiálható, szükség esetén releváns kiszűrés rögzítésével.

A véradó eProgesa személyi lapján a visszavont kiszűrés kódja, neve, időtartama nem jelenik meg *(az eProgesa log fájlból visszakereshető marad).*

TILOS a kiszűrés visszavonását a kiszűrés lezárása helyett alkalmazni! Nem vonható vissza tehát egy korábbi eseményen rögzített kizárás.

Közepes (##) és magas (###) kompetencia szintű kiszűrés központi visszavonása:

Amennyiben közepes (##) vagy magas (###) kompetencia szintű téves kiszűrés került a véradóra, akkor a visszavonást a „Kiszűrés megszüntetését kérő lapon” (DON07_A08) az MBI-t kell kérni annak érdekében, hogy a releváns kiszűrés rögzíthető legyen. Ha a kiszűrés visszavonásra került, a vérellátóban a helyes kiszűrés rögzítésével egy időben, a véradóhoz tartozó megjegyzés rovatba rögzíteni kell, hogy a visszavonásra *„helyben nem javítható adminisztratív hiba*” miatt került sor.

EGYÉB

Tájékoztató levél a véradónak: Azoknál a kiszűréseknél, ahol az „levél” oszlopban szerepel a levélkód, a kiszűrést követő 3. napon *(annak érdekében, hogy a tévesen rögzített kiszűrés javítására legyen lehetőség)* automatikus tájékoztató levél generálódik, és kerül feltöltésbe a TAJ számmal rendelkező véradók EESZT fiókjába.

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
BAKTÉRIUMOK						**(BNO A00-A74)**		
Fertőző bélbetegségek						**(BNO A00-A09)**		
Fertőző eredetű hasmenés	FG01	ÁTMENETI	**14 nap**	↑	Akinek jelenleg hasmenése van vagy két héten belül: • antibiotikum szedéséből eredő hasmenése volt, • 24 óránál hosszabb ideig tartó hasmenése volt, • 24 óránál rövidebb tartó hasmenése volt, de a környezetében élőknek szintén hasmenése volt, • a kezelőorvos fertőző hasmenést állapított meg. Aki két héten belül gyógyult, annál a kiszűrést a gyógyulás napjától kell indítani. Amennyiben Yersinia, Campylobacter, Salmonella, Shigella valamelyikét kimutatták vagy diagnosztizálták, ezt a tényt rögzíteni kell az orvosi megjegyzések között, és a kiszűrési időtartamot fel kell emelni, a gyógyulást követő 30. napra Amennyiben a hasmenés szervi megbetegedés-, allergiás-, vagy táplálkozás eredetű lásd: BG01-BG06		#	
Gümőkór						**(BNO A15-A19)**		
Légzőszervi gümőkór	FT01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04	A kiszűrés a gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Egyéb szervek gümőkórja	FT02	TARTÓS	**végtelen**	↓	Fertőzés kockázata esetén lásd: RF04	A kiszűrés a gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Zoonosisok						**(BNO A20-A28)**		
Brucellosis	FZ01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedést. Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Egyéb bakteriális zoonosis	FZ02	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a más kategóriába nem illeszthető, lelettel alátámasztott bakteriális zoonosisokat. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján, a betegség jellegének megfelelően a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	
Egyéb baktériumok						**(BNO A30-A49)**		
Lepra	FL01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	
Főként szexuális úton terjedő betegségek						**(BNO A50-A64)**		
Syphilis OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FW13	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Anamnézis, klinikai- illetve külső laboratóriumi lelet alapján.		###	
anti-TP konfirmálás folyamatban	FW30	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradási minta anti-TP reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok folyamatban vannak.	A kiszűrés a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.	##	
anti-TP konfirmált-negatív	FW47	TARTÓS	**végtelen**	↓	A konfirmáló vizsgálat nem igazolta a szűrőteszt reaktív eredményt. A szűrőteszt fals reaktivitása miatt a véradó tesztváltásig kizárva. A véradó a szűrőteszt váltásról értesítést kap. Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradó további vizsgálata nem szükséges.	A kiszűrés lezárása a szűrőteszt váltáskor központilag történik.	###	
anti-TP nem igazolt szűrő reaktivitás	FW48	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A konfirmáló vizsgálat bizonytalan. *(A szűrővizsgálati reaktív eredményt aspecifikus ellenanyag is okozhatta, de ez nem igazolt.)* Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradót szakorvoshoz kell irányítani.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
anti-TP pozitív	FW70	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Anti-TP ellenanyag megerősített kimutatása. A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát. Járványügy és gondozó intézet felé jelentve. A véradót a gondozóba kell irányítani.	A kiszűrés nem zárható le külső laboratórium pl.: „gyógyult szifilisz” eredménye alapján!	###	
anti-TP kétes	FW82	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A konfirmáló vizsgálat során az eredmény határozatlan, vagy a pozitívként meghatározott értéknél gyengébb, ezért nem megállapítható, hogy a szűrővizsgálati reaktivitást a vizsgált kórokozóval való fertőzés okozza-e. BNG gondozó intézet felé nem történt jelentés. Abban az esetben, ha kockázati tényezők, vagy jellemző tünetek indokolják javasolható, hogy keressen fel szakorvost.	A kiszűrés nem zárható le külső laboratórium pl.: „gyógyult szifilisz” eredménye alapján!	###	
anti-TP technikai ok miatt nem meghatározható	FW90	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradót automatikus levélben behívták mintaadásra A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát.	A kiszűrés lezárás a minta vizsgálatának eredménye alapján történik.	##	
Egyéb nemi betegség	FN01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált Gonorrhoea Trichomonas, Chlamidia megbetegedés. Nemi herpesz (Herpes simplex) esetén lásd: FK03 A HPV nem kizáró ok, csak ha aktuálisan kezelés alatt van. Kezelés alatt lévő személy esetén a kiszűrést lásd: Műtéti beavatkozás: RA14	Gonorrhoea esetén a kiszűrés a gyógyulást követő egy évvel (365 nap) lezárható Trichomonas, Chlamidia esetén a kiszűrés a gyógyulást követő egy hónappal (30 nap) lezárható.	#	**3660**
Egyéb spirochaeták						**(BNO A65-A69)**		
Lyme-kór (borreliosis)	FO01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés. Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik! Fertőzés kockázata (kullancs-csípés) esetén lásd: RF08 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	Amennyiben nincsenek gyulladásos maradvány tünetek, a kizárás az antibiotikus kezelés befejezést követően egy hónappal (30 nap) lezárható.	#	**3661**
RICKETSIÁK						**(BNO A75-A79)**		
Q-láz	FR01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján lezárható. *Krónikus esetekben a kizárás nem szüntethető meg*	#	
PRIONOK						**(BNO A81)**		
Creutzfeldt-Jakob betegség (CJD és vCJD)	FI01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A kiszűrést PDI bejelentés alapján az MBO végzi. TSE kockázat esetén lásd: RF09		###	
VÍRUSOK						**(BNO A80-B34)**		
A központi idegrendszer vírusfertőzései						**(BNO A80-A89)**		
Veszettség	FI02	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A kiszűrést PDI bejelentés alapján az MBO végzi. Veszettség kockázata esetén lásd: RF02		###	
A központi idegrendszer egyéb vírusai	FI03	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást (k.m.n.) Tünet nélküli kullancscsípést követően lásd: RF08 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	
Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak						**(BNO A90-A99)**		
Dengue láz	FQ03	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF39 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Chikungunya vírus betegség	FQ04	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF40 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	
O' nyong-nyong láz	FQ05	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF07 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	
Venezuelai ló-láz	FQ06	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF07 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	
Nyugat-Nílusi láz (WNV)	FQ07	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés OVSz vizsgálatban NAT pozitív estben lásd: FQ21 Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF38 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	
WNV NAT pozitív	FQ21	ÁTMENETI	**120 nap**	↓	Epidemiológia helyzet miatt szezonálisan végzett NAT szűrővizsgálat alapján WNV pozitív eredményű személy		###	
Zika vírus betegség	FQ08	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés OVSz vizsgálatban NAT pozitív esetben lásd: FQ22 Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF41 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	
Rift Valley láz	FQ09	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF07 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	
Sárgaláz	FQ10	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Epidemiológiai kockázat esetén lásd: RF07 Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 120 nappal lezárható.	#	
Bőr és nyálkahártya elváltozásával járó vírusfertőzések						**(BNO B00-B09)**		
Felnőttkori gyermekbetegségek	FK02	ÁTMENETI	**21 nap**	↑↓	Ide sorolva: • kanyaró (morbilli), • rózsahimlő, rubeola (rubella), • mumpsz (parotitis epidemica), • bárányhimlő (varicella). A kiszűrést az első tünetek kezdő napjával kell indítani. Kanyarós, rubeolás, mumpszos, bárányhimlős beteggel érintkező személyeket a kontaktus napjával kezdődően kell kizárni lásd: RF42 Aki két héten belül gyógyult, annál a kiszűrés a gyógyulás napjától kezdődően 14 napra csökkenthető. *Lepkehimlő esetén a szabályokat lásd : FV03 és FV70*		#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Ajak- és genitális herpesz	FK03	ÁTMENETI	**14 nap**	↑↓	Akiknek a jelentkezéskor az ajak-vagy genitális herpeszfertőzése aktív (fájdalom, bizsergés, seb). **A kiszűrést a tünetek jelentkezésének napján kell indítani.** Az ajak körüli herpeszből eredő nem sebes bőrelváltozás elfogadható, ha nincs fájdalom, vagy bizsergés. A donor szexuális partnerének herpesze nem kizáró ok. *A herpes simplex vírusok (HSV 1 és 2) egyaránt okozhatnak ajak herpeszt és genitális herpeszt. Amikor a vírus aktívan szaporodik, fennáll annak elméleti kockázata, hogy a maga a vírus vagy valamely másodlagos fertőzés transzfúzió útján továbbadható, ezért ezeket a személyeket ki kell zárni.* *Mivel a donorok és a recipiensek körében magas a herpesz vírusoknak való kitettség prevalenciája, a múltban fertőzött donorok kiszűrése nem kivitelezhető és nem is hasznos.*		#	**3657**
Szemölcs	FK04	TARTÓS	**végtelen**	↓	Akinek a szemölcs kiterjed a vérgyűjtéshez használt könyökhajlati véna feletti bőrre. Az orvosi kezelés (égetés, fagyasztás, sebészeti beavatkozás) után lásd: RA14	Az alkalmatlanságot eredményező ok megszűnésével, a kiszűrés a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	
Bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó egyéb vírusfertőzés	FK05	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓	Ide sorolva például: • övsömör (Herpes Varicella Zoster), • majomhimlő (mpox). Aki egy hónapon belül gyógyult, annál a kiszűrést a gyógyulás napjától kell indítani. Majomhimlős beteggel érintkező személyeket a kontaktus napjával kezdődően kell kizárni lásd: RF42 Aki jelenleg beteg, a kiszűrést fel kell emelni 60 napra. Kaposi sarcoma-associated human herpes virus 8 (HHV8) esetén lásd: Rosszindulatú daganat BD01 *Megjegyzés:* *Visszatérő, súlyos esetekben felmerülhet az immunszupresszió gyanúja lásd: BV05*		#	**3658**
Vírusos májgyulladások						**(BNO B15-B19)**		
HAV						**(BNO B15)**		
HAV NAT pozitív	FA70	ÁTMENETI	**365 nap**	↓	A tájékoztatásra jelentkező „§” véradót szakorvoshoz kell irányítani.		###	
HAV OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FA13	TARTÓS	**végtelen**	↓	Külső laboratórium HAV pozitív lelete alapján. Lelet hiányában a kiszűrés FY13	A gyógyulásról szóló szakorvosi lelet alapján, egy évvel (365 nap), a HAV pozitív laboratóriumi eredményt követően lezárható.	#	
HBV						**(BNO B16, B18)**		
HBV OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FB13	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Külső laboratórium HBV pozitív lelet alapján Lelet hiányában a kiszűrés FY13		###	
HBV konfirmálás folyamatban	FB30	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradási minta HBsAg reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok folyamatban vannak.	A kiszűrés a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.	##	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
HBV konfirmált-negatív	FB47	TARTÓS	**végtelen**	↓	A konfirmáló vizsgálat nem igazolta a szűrőteszt reaktív eredményt. A szűrőteszt fals reaktivitása miatt a véradó tesztváltásig kizárva. A véradó a szűrőteszt váltásról értesítést kap. Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradó további vizsgálata nem szükséges.	A kiszűrés lezárása a szűrőteszt váltáskor központilag történik.	###	
HBV nem igazolt szűrő reaktivitás	FB48	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A konfirmáló vizsgálat bizonytalan. *(A szűrővizsgálati reaktív eredményt aspecifikus ellenanyag is okozhatta, de ez nem igazolt.)* Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradót szakorvoshoz kell irányítani.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	
HBV plazmaferezis állomás jelentette pozitív	FB60	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	NAT pozitív eset. A kiszűrést PDI bejelentés alapján az MBO végzi.		###	
HBV pozitív	FB70	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Laboratóriumi módszerekkel kimutatott és megerősített HBV fertőzés. A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát. A véradót szakorvoshoz kell irányítani.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	
anti-HBc reaktív	FB85	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A tájékoztatáson javasolni kell, hogy forduljon szakorvoshoz. *A HBsAg a NAT egyaránt negatív. Valószínűleg korábbi fertőzést átvészelt személy.*	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	
HBV technikai ok miatt nem meghatározható	FB90	TARTÓS	**végtelen**	↓	A HBV meghatározás technikai ok miatt megszakadt A véradótól ismételt minta szükséges. A véradót automatikus levélben behívták mintaadásra A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát.	A kiszűrés lezárás a minta vizsgálatának eredménye alapján történik.	##	
HBV visszavezetés	FB51	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett.	Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.	##	
HCV						**(BNO B17, B18)**		
HCV OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FC13	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Külső laboratórium HCV pozitív lelet alapján, Lelet hiányában a kiszűrés FY13		###	
HCV konfirmálás folyamatban	FC30	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradási minta HCV reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek.	A kiszűrés a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.	##	
HCV konfirmált-negatív	FC47	TARTÓS	**végtelen**	↓	A konfirmáló vizsgálat nem igazolta a szűrőteszt reaktív eredményt. A szűrőteszt fals reaktivitása miatt a véradó tesztváltásig kizárva. A véradó a szűrőteszt váltásról értesítést kap. Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradó további vizsgálata nem szükséges.	A kiszűrés lezárása a szűrőteszt váltáskor központilag történik.	###	
HCV nem igazolt szűrő reaktivitás	FC48	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A konfirmáló vizsgálat bizonytalan. *(A szűrővizsgálati reaktív eredményt aspecifikus ellenanyag is okozhatta, de ez nem igazolt.)* Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradót szakorvoshoz kell irányítani.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	
HCV plazmaferezis állomás jelentette pozitív	FC60	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	NAT pozitív eset. A kiszűrést PDI bejelentés alapján az MBO végzi.		###	
HCV pozitív	FC70	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Laboratóriumi módszerekkel kimutatott és megerősített HCV fertőzés. A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát. A véradót szakorvoshoz kell irányítani.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
HCV kétes	FC80	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A konfirmáló vizsgálat során az eredmény határozatlan, vagy a pozitívként meghatározott értéknél gyengébb, ezért nem megállapítható, hogy a szűrővizsgálati reaktivitást a vizsgált kórokozóval való fertőzés okozza-e. HCV gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradót szakorvoshoz kell irányítani.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	
HCV technikai ok miatt nem meghatározható	FC90	TARTÓS	**végtelen**	↓	A HCV meghatározás technikai ok miatt megszakadt A véradótól ismételt minta szükséges. A véradót automatikus levélben behívták mintaadásra A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát.	A kiszűrés lezárás a minta vizsgálatának eredménye alapján történik.	##	
HCV visszavezetés	FC51	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett. Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.		##	
HEV						**(BNO B17.2)**		
HEV OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FY14	TARTÓS	**végtelen**	↓	Külső laboratórium HEV pozitív lelete alapján. Lelet hiányában a kiszűrés FY13	A gyógyulásról szóló szakorvosi lelet alapján, egy évvel (365 nap), a HEV pozitív laboratóriumi eredményt követően lezárható.	#	
Vírushepatitis k.m.n						**(BNO B19)**		
Hepatitis (k. m. n.) OVSz vizsg. nélkül pozitív	FY13	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ismeretlen eredetű hepatitis anamnézis, illetve vírus azonosító laboratóriumi eredmény nélküli klinikai lelet alapján. Külső laboratóriumi HAV, HEV, HBV és HCV pozitív lelet esetén lásd: FA13 / FB13 / FC13/ FY14 Ismeretlen eredetű sárgaság esetén lásd: DT08		###	
Human immundeficiencia vírus (HIV) betegség						**(BNO B20-B24)**		
AIDS/HIV OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FH13	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Külső laboratórium HIV pozitív lelet alapján. Ideértve azokat is akik HIV kezelés céljából gyógyszeres terápiát kapnak, például ART (antiretrovirális terápa).		###	
HIV konfirmálás folyamatban	FH30	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradási minta HIV reaktív szűrővizsgálati eredménye miatt megerősítő vizsgálatok készülnek.	A kiszűrés a véradási minta konfirmálásának lezárásáig tart.	##	
HIV konfirmált-negatív	FH47	TARTÓS	**végtelen**	↓	A konfirmáló vizsgálat nem igazolta a szűrőteszt reaktív eredményt. A szűrőteszt fals reaktivitása miatt a véradó tesztváltásig kizárva. A véradó a szűrőteszt váltásról értesítést kap. Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. A véradó további vizsgálata nem szükséges.	A kiszűrés lezárása a szűrőteszt váltáskor központilag történik.	###	
HIV nem igazolt szűrő reaktivitás	FH48	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A konfirmáló vizsgálat bizonytalan. *(A szűrővizsgálati reaktív eredményt aspecifikus ellenanyag is okozhatta, de ez nem igazolt.)* Járványügy vagy gondozó intézet felé nem történt jelentés. Abban az esetben, ha kockázati tényezők, vagy jellemző tünetek indokolják javasolható, hogy keressen fel szakorvost.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	
HIV plazmaferezis állomás jelentette pozitív	FH60	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	NAT pozitív eset. A kiszűrést PDI bejelentés alapján az MBO végzi.		###	
HIV pozitív	FH70	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Laboratóriumi módszerekkel kimutatott és megerősített HIV fertőzés. A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát. Járványügynek és gondozó intézetnek jelentve. A véradót a gondozóba kell irányítani.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
HIV kétes	FH80	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A konfirmáló vizsgálat során az eredmény határozatlan, vagy a pozitívként meghatározott értéknél gyengébb, ezért nem megállapítható, hogy a szűrővizsgálati reaktivitást a vizsgált kórokozóval való fertőzés okozza-e. HIV gondozó intézet felé nem történt jelentés. Abban az esetben, ha kockázati tényezők, vagy jellemző tünetek indokolják javasolható, hogy keressen fel szakorvost.	Véradásból véglegesen kizárva. Külső laboratórium negatív eredménye nem elfogadható.	###	
HIV technikai ok miatt nem meghatározható	FH90	TARTÓS	**végtelen**	↓	A HIV meghatározás technikai ok miatt megszakadt A véradótól ismételt minta szükséges. A véradót automatikus levélben behívták mintaadásra. A véradó tájékoztatása előtt át kell tekinteni a vizsgálati eredményeket és a véradó státuszát.	A kiszűrés lezárás a minta vizsgálatának eredménye alapján történik.	##	
HIV visszavezetés	FH51	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett.	Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy tartós/végleges kiszűrésre változik.	##	
Egyéb vírusbetegségek						**(BNO B25-B34)**		
Mononucleosis infectiosa	FV01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Diagnózis nélküli nyirokcsomó megnagyobbodás esetén lásd: DT14	A kiszűrés a gyógyulást követő fél évvel (180 nap) lezárható.	#	
HTLV I/II OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FV02	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Külső laboratórium lelet alapján.		###	
Parvo B19 OVSz vizsgálat nélkül pozitív	FV03	ÁTMENETI	**35 nap**	↑	Külső laboratórium Parvo B19 pozitív lelet alapján. Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25 *(Kontaktus esetén a donort nem kell kizárni.)*		#	
Parvo B19 NAT pozitív	FV70	ÁTMENETI	**35 nap**	**Ø**			###	
MYCOSISOK						**(BNO B35-B49)**		
Mycosis	FM01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a **sebesedő, a mélyebb szöveteket** vagy **szerveket érintő** gombás megbetegedéseket. Ide sorolva a **száj nyálkahártyáját** érintő gombás megbetegedéseket. *A szájpenész egészséges felnőtteknél nem gyakori, ezért ha nincs antibiotikum szedés vagy szteroid kezelés az anamnézisben, a kezelés befejezését követő egy héten belül visszatérő fertőzés immunszupresszó gyanúját veti fel. Ebben az esetben Lásd: BV05* *Megjegyzés:* *A **genito-anális gombásodás** (pl. Candida), a fedett felületen lévő **krónikus bőrgomba** (pl. lábgomba) és a **körömgomba** egészséges felnőtteknél is gyakori. Ha nem merül fel immunszupresszió gyanúja, és a véradó nem számol be gyulladt, mélyebb szövetekre terjedő gennyes sebekről, a betegség illetve a kezelés nem befolyásolja az alkalmasságot.*	A kiszűrés a betegség megszűnését, illetve a kezelés befejezését követő két héttel lezárható.	#	**3659**
PROTOZOONOK						**(BNO B50-B64)**		
Malária	FP01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés. Malária fertőzés kockázata esetén lásd: RF05 Malária fertőzés kiemelt kockázata esetén lásd: RF06 Malária hordozás kockázata, vagy a kockázatos területről való visszatérést követő 180 napon belüli ismeretlen lázas állapot esetén: RF35		###	
Leishmaniasis (Kala-azar)	FP02	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés. Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25		###	
Chagas-betegség (tripanosomiasis)	FP03	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés. Chagas-betegség hordozás kockázata: RF36		###	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Toxoplasmosis	FP04	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően 180 nappal, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Babesiosis	FP05	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a diagnosztizált megbetegedés. Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25		###	
EGYÉB FERTŐZŐ BETEGSÉGEK						**(BNO B65-B99)**		
Helminthiasis	FF01	ÁTMENETI	**30 nap**	↑			#	
Élősdiek által okozott fertőzés	FE01	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Például: tetű, rüh.		#	
Egyéb fertőző betegség	FX99	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a jelen táblázatban tételesen nem szereplő diagnosztizált fertőző betegségeket: pl.: szamárköhögés (Bordetella Pertussis), orbánc (erysipelas), kéz-láb-száj betegség (enterovirusos vesicularis stomatitits kiütéssel) **A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.** Megbetegedés gyanúja esetén irányítsa szakorvoshoz: RA25	A kiszűrés a gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	
Egyéb fertőző betegség visszavezetés	FX51	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradó pillanatnyilag visszavezetési eljárásban érintett.	Az eljárás után a kiszűrés megszűnik, vagy végleges kiszűrésre változik.	##	
DAGANATOK						**(BNO C00-D48)**		
Rosszindulatú daganat	BD01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Lokalizáció meghatározása nélkül. Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik! Diagnosztizált in situ daganat a teljes gyógyulása után (pl.: basalioma, cervicalis carcinoma in situ) nem kizáró ok. *Vigyázat, basalioma esetén teratogén gyógyszer alkalmazása is felmerülhet! Lásd: RA11*		###	**3607**
Nyirok és vérképző szervek daganata	BD02	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A nyirok- vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganatai. Külön kategóriába sorolva a lymphoma és a leukemia lásd BD04. Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik!		###	**3608**
Ismeretlen természetű daganat	BD03	TARTÓS	**végtelen**	↓	Diagnózis nélkül, a donor beszámolója alapján eltávolított daganat. Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik! Neurofibromatózis esetén, amennyiben betegség kizárólag bőrtünetekben manifesztálódik és ezek lokalizációja nem akadályozza meg a véna punkciót és vérvételt, akkor véradásra alkalmas.	A kiszűrés az ismeretlen daganat műtéti gyógyulást követően negatív szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	**3609**
Lymphoma és leukemia	BD04	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	**3610**
VÉR ÉS A VÉRKÉPZŐ SZERVEK ÉS AZ IMMUNRENDSZER BETEGSÉGEI						**(BNO D58-D89)**		
β-thalassaemia	BV01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	β-thalassaemia heterozigóta hordozó, amennyiben jó egészségben van és hemoglobin szintje az elfogadható értékhatárok között van, véradásra alkalmas.		###	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Anaemia gyanú, vagy ismételten alacsony hemoglbin szint	BV02	TARTÓS	**végtelen**	↓	Akiknek az elmúlt két évben -beleértve a jelenlegi mérést is- legalább 4 alkalommal határérték alatti hemoglobin szintet mértek (a bizonylaton az elmúlt két évben legalább három DL05 kizárás). *Ide sorolva a bemutatott szakorvosi leleten diagnosztizált anaemia is.*	A kiszűrés szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	**3647**
Hemofília	BV03	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide értve valamennyi hemofília, és ide sorolva a kórelőzményben szereplő véralvadási zavart is. Nem ide értve a gyógyszer okozta véralvadási zavarok. Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor vérkészítményt kapott.		###	**3648**
Egyéb, vérképzőszervi betegség, vagy pontosan meg nem határozott véralvadási zavar	BV04	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva például, ha a véradó lelet bemutatása nélkül véralvadási zavarokról számol be. Ide értve a feltételezetten gyógyszer által kiváltott véralvadási zavart. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. *Diagnózis nélküli, tapintható lépmegnagyobbodás esetén lásd: DT07* *Thrombosis, embólia, thrombophilia esetén lásd: BK11 BK12*	A kiszűrés szakorvosi lelet bemutatása után lezárható, szükség esetén a megfelelő új kiszűrés alkalmazása mellett.	#	**3649**
Immunrendszert érintő rendellenesség	BV05	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva például az immunhiány, hypergamma-globuliaemia stb., továbbá ha a véradó lelet bemutatása nélkül „immunológiai zavarokról” számol be. *Az IgA hiánybetegség nem kizáró ok.* A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. FONTOS: *Az immunszuppresszió elfedheti a szervezet normális válaszát bizonyos fertőző és gyulladásos állapotokra.* *Ez fertőző betegségek átvitelét eredményezheti.* **Az autoimmun betegségeket a** BNO szerint aza alábbiak szerint kell kiszűrni: Asthma: BL07; Cöliákia: BE04; Ekcéma:BB01; Hashimoto-thyreoiditis: BE06; Psoriasis: BB02; Rheumatoid arthritis:BC01; Sclerosis multiplex: BI04; Vitiligo: BB01; Kötőszövetet is érintő **szisztémás autoimmun betegségek** esetén (SLE, MCTD, APS, Sjörgen stb) : BC03;	A kiszűrés szakorvosi lelet bemutatása után lezárható, szükség esetén a megfelelő új kiszűrés alkalmazása mellett. Guillain-Barre szindróma (GBS) esetén a kiszűrés lezárásának feltételei: • szakorvosi lelet alapján maradéktalanul gyógyult, • a gyógyulás óta legalább két év (24 hónap) eletelt, • a betegség kevesebb, mint 12 hónap alatt lezajlott, • a betegség egy hullámban -kiújulás nélkül-, futott le, • első alkalommal volt a jelentkezőnek GBS-e.	#	
Polycythaemia rubra vera	BV06	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik!		###	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
ENDOCRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉG						**(BNO E00-E90)**		
Pajzsmirigy betegség	BE01	TARTÓS	**végtelen**	↓	Pajzsmirigy túlműködés, gyulladás, rosszindulatú megbetegedés, pajzsmirigy betegség kivizsgálás alatt. Diagnosztizált Hashimoto-thyreoiditis esetén lásd: BE06. Ide sorolva azokat a személyeket is, akiknél pajzsmirigy rendellenesség miatt izotópkezelést alkalmaztak. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni.	Pajzsmirigy túlműködés esetén alkalmazott kezelésnél, annak bejezése után két évvel (24 hónap), szakorvosi lelet alapján a kiszűrés lezárható. Pajzsmirigy alulműködés esetén akkor zárható le kiszűrés, ha: • panasz és tünetmentes, • kivizsgálás megtörtént, a hormonszint beállítás legalább három hónapja (90 nap) befejeződött (szakorvosi lelet bemutatása követelmény), • a hormonpótláson kívül más kezelést nem kap • a stabil fenntartó hormonkezelést egy hónapon belül (30 nap) nem változtatták *(hormonszint ellenőrzésről lelet bemutatása évenként javasolt*) Fertőzés eredetű, gyógyszer vagy trauma okozta pajzsmirigy gyulladás esetén, a kiszűrés a gyógyulást követő fél évvel (180 nap), szakorvosi lelet alapján lezárható. Izotóp kezelés esetén a kiszűrés a betegségtől függetlenül fél évig (180 nap) nem zárható le. Rosszindulatú betegség és Graves–Basedow-kór esetén a kiszűrés nem zárható le.	#	**3611**
Hashimoto-thyreoiditis	BE06	TARTÓS	**végtelen**	↓	A kivizsgálási és hormonszint beállítási időszak után, a pajzsmirigy hormonkezeléssel karbantartott, panasz és tünetmentes pajzsmirigy betegség nem kizáró ok. Szakorvosi lelet bemutatása követelmény. A pajzsmirigy-hormon kezelésen kívül egyéb gyógyszeres kezelés esetén (pl. szteroid) a donort ki kell szűrni és a gyógyszer nevét az orvosi megjegyzések között rögzíteni kell. Ugyanez vonatkozik az utólagosan bejelentett betegségre is (PDI).	Diagnosztizált Hashimoto-thyreoiditis esetén akkor zárható le kiszűrés, ha: • panasz és tünetmentes, • a hormonszint beállítás legalább három hónapja (90 nap) befejeződött (szakorvosi lelet bemutatása követelmény), • a hormonpótláson kívül más kezelést nem kap, • a stabil fenntartó hormonkezelést egy hónapon belül (30 nap) nem változtatták *(hormonszint ellenőrzésről lelet bemutatása évenként javasolt)*	#	**3616**
Cukorbetegség	BE02	TARTÓS	**végtelen**	↓	Inzulinfüggő esetben a kiszűrés kötelező (!) Diétával, vagy NEM INZULIN antidiabetikummal (talb, inj.) legalább egy hónapja változatlan gyógyszereléssel, stabilan karbantartott személyek a kivizsgáló megítélése szerint adhatnak vért.	A kiszűrés gyógyszeresen egyensúlyban tartott esetben, szakorvosi lelet alapján, a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	**3612**
Egyéb endocrin rendellenesség	BE03	TARTÓS	**végtelen**	↓	Amennyiben a kiszűrés indokolt, a kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.	Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	**3613**
Anyagcsere rendellenesség	BE04	TARTÓS	**végtelen**	↓	A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. *A diétával egyensúlyban tartott, tünetmentes cöliákia nem kizáró ok.* *Emelkedett húgysav szint, illetve tünetmentes köszvény nem kizáró ok.* *Aktuálisan tünetmentes Gilbert-kór nem kizáró ok.* *Lásd még: DT08*	Gyógyulást követően, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	**3614**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Haemochromatosis	BE05	TARTÓS	**végtelen**	↓	A génmutáció igazolása önmagában nem ok a kiszűrésre! A véradó által közölt diagnózis mellett akkor alkalmas, ha nincs manifesztálódott cukorbetegség, arthopatia, szív, vagy tüdő érintettség, bőr elváltozás, stroke előzmény, és minden egyéb szempontnak megfelel.		#	**3615**
MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS-ZAVAROK						**(BNO F00-F99)**		
Alkoholos állapot, vagy tudatmódosító szer hatása alatt	BM01	ÁTMENETI	**3 nap**	↑↓	Befolyásoló tényező és a befolyásoltság mértéke szerint változtatható		#	
Alkoholizmus	BM02	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés a gyógyulást követően lezárható.	#	
Drog, pszichoaktív anyag rendszeres használata	BM03	TARTÓS	**végtelen**	↓	Drogok vagy pszichoaktív anyagok befolyásoló hatása alatt álló személy (függőségre utaló jel nélkül). Iv. kábítószer fogyasztó esetén lásd: RF03.	A függőségre utaló jel nélküli esetben a kiszűrés a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	
Súlyos mentális elmaradottság	BM04	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	
Mentális rendellenesség	BM05	TARTÓS	**végtelen**	↓	Schizophrenia kivételével ide sorolva a súlyos depressziós és pszichotikus beteget is. Schizophrenia esetén lásd: BM06 A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. *A depressziós, szorongásos betegséget ki kell zárni, ha:* • *súlyos, gyógyszeres kezelés ellenére szorongásos vagy érzelmi rendellenességre utaló tüneteket mutat,* • *a kezelésre lítium tartalmú gyógyszert alkalmaznak.* *A figyelemzavaros, hiperaktív- és hangulati betegségben szenvedőket (pl. ADHD) ki kell zárni, ha:* • *aktuálisan érzelmi rendellenességre utaló tüneteket mutat,* • *nem érti teljes mértékben az űrlapon feltett kérdéseket,* • *nem adja meg a szükséges beleegyező nyilatkozatokat,* • *aktuális állapota akadályozza a véradási eljárást.* *Ha a donor a véradási feltételeknek megfelel, a gyógyszerek szedése önmagában nem befolyásolja az alkalmasságot.* Magatartással kapcsolatos rendellenesség esetén lásd: DT10	A gyógyult személyek esetén (pl trauma által kiváltott depresszió rendeződése esetén) a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	**3642**
Schizophrenia	BM06	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik!		###	**3643**
AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI						**(BNO G00-G99)**		
Parkinson-kór	BI01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	**3619**
Epilepsia	BI02	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradó alkalmas, ha öt évet meghaladóan gyógyszer- és tünetmentes. Szakorvosi lelet bemutatása követelmény. Ismeretlen eredetű eszméletvesztéssel járó állapotok esetén: DT13.	Legalább öt évet meghaladóan gyógyszer- és tünetmentes esetben a kizárás szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	**3620**
A központi idegrendszer egyéb betegsége	BI03	TARTÓS	**végtelen**	↓	Sclerosis multiplex kivételével. Sclerosis multiplex esetén lásd: BI04 A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. pl. Alzheimer, Huntigton stb.	A kiszűrés a gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	**3621**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Sclerosis multiplex	BI04	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik!		###	**3622**
A SZEM BETEGSÉGEI						**(BNO H00-H59)**		
Nem fertőző súlyos szembetegségek	BS01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a retinaleválás *(ismétlődés veszélye miatt);* továbbá a daganat, önálló autoimmun betegség Szisztémás autoimmun betegség manifesztációja esetén lásd: BC03		###	**3644**
Zöldhályog (glaucoma)	BS02	TARTÓS	**végtelen**	↓	Kezeletlen, vagy kevesebb, mint egy hónapja azonos készítménnyel történő kezelés esetén (különösen béta receptor blokkoló szemcseppek).	A korábbi szabályok szerint kiszűrt személyek nem kerülnek automatikusan visszavételre, de ha a korábban ezzel az okkal kizárt véradó újból jelentkezik, akkor a kivizsgálónak módja van az általános belgyógyászati állapot alapján a kiszűrés lezárására.	#	
Fertőző vagy gyulladásos szembetegség	BS04	ÁTMENETI	**14 nap**	↑	Aktív szemgyulladás vagy fertőzés. A 14 napos kiszűrés az enyhe, kezelt esetekre (elsősorban kötőhártya gyulladás) vonatkozik. Súlyos gyulladások, iritis-, scleritis esetén az kivizsgáló belátása szerint növelje a kiszűrési időt. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni.		#	**3645**
Egyéb szembetegség	BS03	TARTÓS	**végtelen**	↓	A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. Makuladegeneráció *intravitreális* (üvegtestbe adott) injectiós kezelése, továbbá jóindulatú megbetegedések sebészeti kezelése esetén lásd: RA14 Szemből származó allogén szövet átültetése esetén lásd: RF09	A jóindulatú betegség esetén a kiszűrés a gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően, a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	
A FÜL BETEGSÉGEI						**(BNO H60-H95)**		
Külsőfül-betegség	BF01	ÁTMENETI	**14 nap**	↑			#	
Középfül-betegség	BF02	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓			#	
Belsőfül-betegség	BF03	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓			#	
Kommunikációt zavaró süketség	BF04	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés helyreállt kommunikációs képesség esetén lezárható.	#	
A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI						**(BNO I00-I99)**		
Rheumás láz a szív érintettsége nélkül	BK01	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés a tünetek megszűnésének időpontjától számítva 2 év múlva, szakorvosi lelet alapján lezárható, amennyiben nincs krónikus szívbetegségre utaló jel.	#	
Rheumás szívbetegség	BK02	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	
Angina pectoris	BK03	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	**3623**
Szívinfarktus	BK04	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	**3624**
Heveny szívbelhártya-, illetve szívburok gyulladás	BK05	TARTÓS	**végtelen**	↓		A gyógyulástól számítva 2 év múlva, szakorvosi lelet alapján lezárható, amennyiben a betegség visszamaradt elváltozás nélkül gyógyult.	#	**3625**
Heveny szívizomgyulladás	BK06	TARTÓS	**végtelen**	↓		A gyógyulástól számítva 2 év múlva, szakorvosi lelet alapján lezárható, amennyiben a betegség visszamaradt elváltozás nélkül gyógyult.	#	**3626**
Szívritmuszavar	BK07	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a pacemakerrel élők is. Diagnózis nélküli szívverési rendellenesség esetén lásd: DT01	Ha a donornak szívritmuszavara volt (pl. pitvarfibrilláció, pitvarlebegés, szupraventricularis tachycardia, kamrai tachycardia stb.) a kiszűrés akkor sem szüntethető meg, ha tünetei rendeződtek (ide értve az ingerképző góc- vagy ingervezető pálya katéteres ablációját követő ritmuszavar rendeződés is).	###	**3627**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Szívelégtelenség	BK08	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Diagnózis nélküli szívzörejek esetén lásd: DT02		###	**3628**
Cerebrovascularis betegség	BK09	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Például: agyvérzés, agyi trombózis vagy embólia.		###	**3629**
Atherosclerosis	BK10	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Panaszokkal, tünetekkel járó esetben.		###	**3630**
Thrombophilia és thrombophilia eredetű thrombosis és embólia	BK11	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide értve az embóliát, mélyvénás trombózist és a felületes vénás trombózist abban az esetben, ha: • thrombophiliat genetikusan igazolták: Antitrombin, Protein C és Protein S hiány, V. faktor Leiden és protrombin génmutációk. • szerzett thrombophiliat igazoltak: rosszindulatú daganat, autoimmun betegség (*Szerzett thrombphilia esetén a kiváltó betegséggel is ki kell zárni, lásd autoimmun betegség BC03)* *A (család-genetikai vizsgálatokkal felismert) genetikailag diagnosztizált thrombophilia esetén az elfogadás feltétele, hogy a donor:* • *nem hordoz homozigóta Leiden mutációt és* • *soha nem volt trombózisos epizódja és* • *nem kap antitrombotikus terápiát és* • *nem kezelték antitrombotikus terápiával visszatérő terhesség elvesztése miatt.*		###	**3631**
Trombózis és embólia	BK12	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva, akinek anamnézisében: • ismétlődő trombózis szerepel az alsó végtagokon, *(Az anamnézisben szereplő egyszeri, szokványos lokalizációjú trombózis nem kizáró ok.)* • egyszeri embóliája volt, • nem szokványos lokalizációjú trombózisa volt, *(Egyszeri nem szokványos lokalizációjú trombózis (például hónaljban) esetén akkor alkalmas, ha a kiváltó okot azonosították és az megszűnt <például baleset, műtét, extrém sport, speciális munkavégzés>).* • a trombózis érelmeszesedéssel hozható összefüggésbe, • a trombózis okaként thromboticus thrombocytopeniát diagnosztizáltak. Amennyiben a donor kórtörténetében genetikai vizsgálattal igazolt, vagy szerzett thrombophilia szerepe, (egyszeri esemény esetén is) lásd: BK11.		###	**3632**
Visszérgyulladás és felületes vénás trombózis	BK13	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓	Fennálló, vagy kevesebb, mint egy hónapja gyógyult felületes vénás trombózis, vagy visszér gyulladás. *Az anamnézisben szereplő thrombophlebitis előfordulása önmagában nem kizáró ok.* Amennyiben a donor kórtörténetében genetikai vizsgálattal igazolt thrombophilia szerepel, akkor lásd: BK11 A varikózus vénák kezelésére alkalmazott kezelések esetén, a szkleroterápia, abláció, valamint érintett vénák műtéti eltávolítása esetén lásd: RA 14	Sebesedés esetén, a kiszűrést hosszabbítani szükséges.	#	**3633**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Magasvérnyomás betegség	BK14	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓	Ide sorolva, ha a véradó a kezelés ellenére súlyos magas vérnyomásról, vagy vérnyomás ingadozásról számol be. A kivizsgálás során határértéken belüli, gyógyszeres kezeléssel karbantartott, komplikáció nélküli vérnyomásbetegség elfogadható. A kivizsgálás során mért magas vérnyomás esetén diagnózis nélkül DT03		#	**3634**
A LÉGZŐRENDSZER BETEGSÉGEI						**(BNO J00-J99)**		
Allergiás rhinitis	BL05	ÁTMENETI	**aznap**	↑	Az alkalmasság feltétele, hogy a véradásra jelentkező személynek a véradás napján ne legyenek allergiás tünetei (tüsszögés, köhögés). Az allergia kezelésére alkalmazott szemcsepp, orrcsepp, anti-hisztamin, vagy más (nem szteroid!) anti-allergiás gyógyszer szedése mellett engedélyezett a véradás.		#	
Felső légúti fertőzés	BL03	ÁTMENETI	**14 nap**	↑	Ide sorolva például: • megfázás, • nátha, • rhinitis, • orr-, garatgyulladás; • orrmelléküreg gyulladás. Aki két héten belül gyógyult, annál a kiszűrést a gyógyulás napjától kell indítani, Krónikus és visszatérő esetben (pl. krónikus melléküreg gyulladás) a kiszűrést a kivizsgáló megítélése szerint hosszabbítani kell (a döntést a megjegyzésekhez rögzíteni kell). Influenza és influenzához hasonló megbetegedés lásd: BL04 Tüdőgyulladás esetén lásd: BL10 Súlyos aktív broncitis esetén lásd: BL06 Kórházi ellátást igénylő COVID-19 esetén lásd: BL09 **Megjegyzés:** Gyógyultnak tekinthető az a személy: • *nincsenek légúti tünetei és* • *legalább 3 napja láztalan és* • *befejeződött a gyógyszeres kezelése.*		#	**3635**
Influenza, és influenzához hasonló megbetegedés	BL04	ÁTMENETI	**14 nap**	↑	Influenza vagy influenzához hasonló megbetegedés, ide sorolva a kórházi ellátást nem igénylő Covid19 eseteket is. Aki két héten belül gyógyult, annál a kiszűrést a gyógyulás napjától kell indítani, Szövődményes esetben a kiszűrést a kivizsgáló megítélése szerint hosszabbítani kell (a döntést a megjegyzésekhez rögzíteni kell). Súlyos, kórházi ápolást igénylő COVID-19 esetén lásd: BL09 **Megjegyzés:** Gyógyultnak tekinthető az a személy: • *az első tünetek megjelenése óta legalább 10 nap eltelt* • *nincsenek légúti tünetei és* • *legalább 3 napja láztalan és* • *befejeződött a gyógyszeres kezelése.*		#	**3636**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Tüdőgyulladás	BL10	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Aki egy hónapon belül gyógyult, annál a kiszűrést a gyógyulás napjától kell indítani, **Megjegyzés:** Gyógyulási kritériumokat lásd: BL04		#	**3641**
Aktív súlyos bronchitis	BL06	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Aki egy hónapon belül gyógyult, annál a kiszűrést a gyógyulás napjától kell indítani, Krónikus és visszatérő esetben a kiszűrést a kivizsgáló megítélése szerint hosszabbítani kell (a döntést a megjegyzésekhez rögzíteni kell). Idült légzési nehézség esetén lásd: BL08 **Megjegyzés:** Gyógyulási kritériumokat lásd: BL04		#	**3637**
Asthma bronchiale	BL07	TARTÓS	**végtelen**	↓	Véradásra alkalmas a legalább két éve tünetmentes véradó, ha nem kap szteroid kezelést. Inhalációs kezelés mellett (szteroid is) alkalmas abban az esetben, ha terhelhető (például sportolhat).	Fennálló kiszűrés szakorvosi lelet bemutatása esetén lezárható.	#	**3638**
Idült légzési elégtelenség	BL08	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide értve az olyan légzőszervi megbetegedéseket, amelyek nyugalmi állapotban vagy minimális terhelés mellett légszomjat eredményeznek. például: tüdőtágulat, hörgőtágulat (bronchiectasia) Diagnózis nélküli nehézlégzés esetén lásd: DT05		###	**3639**
Kórházi ellátást igénylő COVID-19 megbetegedés	BL09	ÁTMENETI	**30 nap**	**Ø**	A kiszűrést a kórházi kezelés befejezésével kell indítani		#	**3640**
EMÉSZTŐRENDSZER BETEGSÉGEI						**(BNO K00-K93)**		
Gyomor-, nyombél fekély	BG01	ÁTMENETI	**180 nap**	↑↓			#	
Crohn-betegség	BG02	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	**3617**
Colitis ulcerosa	BG03	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	**3618**
Idült nem fertőző májbetegség	BG04	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Diagnózis nélküli májmegnagyobbodás esetén lásd: DT06		###	
A hasnyálmirigy betegsége	BG05	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés nem ismétlődő, egyszeri akut hasnyálmirigy gyulladás esetén (pl. epekő eredetű) a gyógyulást követő egy év múlva (365 nap) a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	
Az emésztőrendszer egyéb betegsége	BG06	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva a nem fertőző eredetű hasmenést is. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni. *Diagnosztizált irritábilis bél szindróma (IBS) nem kizáró ok, amennyiben tünetmentes, és az IBD-t kizárták (Crohn-betegség, colitis ulcerosa).* Fertőző eredetű hasmenések esetén lásd: FG01	A kiszűrés a gyógyulást követően a betegség jellegének megfelelően a kivizsgáló megítélése szerint lezárható.	#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
A BŐR ÉS A BŐR ALATTI SZÖVET BETEGSÉGEI						**(BNO L00-L99)**		
Bőrelváltozások, sebek	BB01	ÁTMENETI	**90 nap**	↑↓	Kiterjedt, kóros bőrelváltozások vagy sebek, különösen a könyökhajlatban. Pattanásos bőr antibiotikumos kezelése nem befolyásolja az alkalmasságot, amennyiben nem gennyes-gyulladt a bőrelváltozás. A szisztémás gyógyszerekkel nem kezelt, nyugodt állapotú vitiligo és ekcéma nem kizáró ok, ha a vérvétel helyét nem érinti. Külön kategóriba sorolva Psoriasis lásd: BB02 Bőrtünetek esetén (pl.: urtikária) lásd: DT09 Vigyázat, teratogén gyógyszer alkalmazása is felmerülhet! Lásd RA11		#	
Psoriasis	BB02	TARTÓS	**végtelen**	↓	Enyhe, szisztémás gyógyszerrel nem kezelt pikkelysömör nem kizáró, ha a sérülések nem fertőzöttek, nincsenek szisztémás tünetek, és a vénaszúrás helyét nem érinti. Utólagos bejelentés esetén (PDI), az orvosi megjegyzések között kötelező rögzíteni, ha a donor betegségét gyógyszeresen kezelik! Vigyázat, teratogén gyógyszer alkalmazása is felmerülhet! Lásd RA11	A kiszűrés gyógyult, tünetmentes esetben az alkalmazott gyógyszer figyelembe vételével zárható le. *(a DON-06_A01 –ben nem szereplő gyógyszer esetén 6 hónap a gyógyszer befejezése után)*	#	
A CSONT, AZ IZOM ÉS A KÖTŐSZÖVET BETEGSÉGEI						**(BNO M00-M99)**		
Rheumatoid arthritis	BC01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	
Egyéb ízületi betegség	BC02	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés a gyógyulást követően lezárható. (Ízületbe adott kortikoszteroid injekciót követően a kizárás legalább 14 nap.)	#	
Autoimmun betegség	BC03	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Szisztémás autoimmun betegségek, többnyire kötőszöveti érintettséggel pl. SLE, SCc, MCTD, APS, Sjörgen betegség, Behcet betegség. Minden IMURAN-nal kezelt autoimmun beteget kötelező kiszűrni!		###	
Ischias	BC04	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓			#	
Súlyos osteoporosis	BC05	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A csontritkulás mértékét nem meghaladó csont denzitás csökkenés (kevesebb, mint: -2,5) nem kizáró ok, kivéve, ha az osteopeniát szisztémás monoklonális ellenanyaggal kezelték.		###	
Osteomyelitis	BC06	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés a gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Egyéb csontrendellenességek	BC07	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban kell részletezni, például: csontelhalás.		###	
AZ UROGENITÁLIS RENDSZER MEGBETEGEDÉSEI						**(BNO N00-N99)**		
Akut glomerulonephritis	BU01	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés a gyógyulást követően 2 évvel, szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Krónikus vesebetegség	BU02	TARTÓS	**végtelen**	↓		Tünet és panaszmentes személyeknél a korábbi, bemondásra vagy vizelet fehérje mérésre alapozott (legalább 2 éves) kiszűrést a kivizsgáló megfelelő indoklással lezárhat.	#	
Húgyhólyag-gyulladás	BU03	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓			#	**3646**
Férfi nemi szervek gyulladásos betegsége	BU04	ÁTMENETI	**30 nap**	↑			#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
A női medence gyulladása	BU05	ÁTMENETI	**90 nap**	↑↓			#	
VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK						**(BNO Q27)**		
Vénahiány a vérvételi helyen	BR01	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés a vénapunkciót végző munkatárs megítélése szerint lezárható.	#	
PANASZOK, TÜNETEK, KÓROS LELETEK DIAGNÓZIS NÉLKÜL						**(BNO R00-R99)**		
Panaszok tünetek						**(BNO R00-R69)**		
A szívverés rendellenessége (EKG nélkül)	DT01	ÁTMENETI	**7 nap**	↑↓	Határérték alatti vagy fölötti pulzusszám és/vagy szabálytalan pulzus (legalább 50, legfeljebb 100).		#	
Szívbetegségre utaló tünet	DT02	TARTÓS	**végtelen**	↓	A kivizsgálás során észlelt szívbetegségre utaló tünet, például szívzörej. A donor elmondása alapján fennálló, diagnózis nélküli vagy kivizsgálás alatt lévő, nem definiált szívbetegség esetén lásd: RA25	A kiszűrés szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	**3652**
Magas vérnyomás (diagnózis nélkül)	DT03	ÁTMENETI	**7 nap**	↑↓	A kivizsgáláskor mért magas vérnyomásérték (systolés érték 180 Hgmm fölött, diastolés érték 100 Hgmm fölött).		#	**3653**
Alacsony vérnyomás (diagnózis nélkül)	DT04	ÁTMENETI	**7 nap**	↑↓	A kivizsgáláskor mért alacsony vérnyomásérték (systolés érték 100 Hgmm alatt).		#	
Nehézlégzés	DT05	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrést követő több mint egy hónap múlva (30 nap) tünetmentesen jelentkező személynél szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Máj megnagyobbodás	DT06	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrést követő több mint három hónap múlva (90 nap) tünetmentesen jelentkező személynél szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Lép megnagyobbodás	DT07	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrést követő több mint három hónap múlva (90 nap) tünetmentesen jelentkező személynél szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
Sárgaság	DT08	TARTÓS	**végtelen**	↓	A szem ínhártyáján valamint a bőrön és a nyálkahártyán látható aktuális sárgaság.	Tünetmentesség esetén a kiszűrés lezárható: • *lelettel igazolt Gilbert-kór esetén (eProgesában nyilvántartott lelet alapján is), vagy* • *a rosszindulatú betegséget és a hepatitis vírus eredetet (HAV/HBV/HCV) kizáró lelet alapján.*	#	
Bőrtünetek	DT09	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓	Például: urticaria, erythema, cyanosis, flush, nyirkos- sápadt bőr.		#	**3654**
Magatartással kapcsolatos eltérések	DT10	TARTÓS	**végtelen**	↓	Különös tekintettel a **csalás; megtévesztő magatartás**. Ide sorolva egyéb megmagyarázhatatlan magatartásbeli problémákat: **például a véradástól való aránytalan félelem**, alacsony szintű személyes higiéne. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.	A fennálló kiszűrést a kivizsgáló belátása szerint lezárhatja.	#	**3655**
Lázas állapot (diagnózis nélkül)	DT11	ÁTMENETI	**14 nap**	**Ø**	A jelentkezéskor 37,5°C elérő, vagy azt meghaladó hőemelkedés, vagy az elmúlt két hétben 38,0°C –t meghaladó lázas megbetegedés, légúti tünetek nélkül. Aki két héten belül gyógyult, annál a kiszűrést az utolsó lázas naptól kell indítani. Légúti tünetes megfázásos megbetegedés esetén lásd BL03		#	
Rossz közérzet	DT12	ÁTMENETI	**7 nap**	↑↓	A véradásra jelentkezéskor kínzó fejfájás, fáradtság, levertség, pihenés hiánya, gyengeség, táplálkozás problémák.		#	
Ismeretlen eredetű eszméletvesztés	DT13	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Például: ismételt görcs; syncope; collapsus a kórelőzményben, kivéve a gyermekkori görcsrohamokat. Epilepszia: lásd BI02		###	**3656**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Nyirokcsomó megnagyobbodás	DT14	TARTÓS	**végtelen**	↓	Diagnosztizált Mononukleosis infec. esetén: FV01	A kiszűrést követő több mint három hónap múlva (90 nap) tünetmentesen jelentkező személynél lezárható.	#	
Súlyhatár alatti donor	DT15	TARTÓS	**végtelen**	↓	A donor testtömege nem éri el az 50 kg-ot.	A követelmény teljesülése esetén lezárható.	#	
Súlyhatár feletti donor	DT17	TARTÓS	**végtelen**	↓	A donor testtömege több, mint 140 kg. Teljes vért adóknál és ciroferezisesés véradóknál az aktuálisan használt ágy teherbírásának megfelelően a kivizsgáló engedélyezheti a nagyobb testtömeget is. Konvaleszcens plazmadonor esetén a felső határ nem léphető át.	A követelmény teljesülése esetén lezárható.	#	
Eritrocita ferezishez túl alacsony testmagasság	DT16	TARTÓS	**végtelen**	↓	A donor testmagassága nem éri el az 170 cm-t.		#	
A vérvizsgálat kóros és rendellenes eredményei						**(BNO R70-R79)**		
Határértéken kívüli trombocita szám	DL03	ÁTMENETI	**7 nap**	↑	A trombocitaszám 150 G/l, vagy annál kevesebb, vagy több, mint 500 G/l		#	
Határértéken kívüli plazmafehérje szint	DL04	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓	Sorozatos plazmaferezis esetén: a szérum összfehérje 60,0 g/l, vagy annál kevesebb, a szérum kvantitatív albumin 40,0 g/l, vagy annál kevesebb, a szérum kvantitatív IgG 7,0 g/l, vagy annál kevesebb. **a kiszűrési időt csak a szakmai főigazgató-helyettes csökkentheti*		#	
Határértéken kívüli fehérvérsejt szám	DL02	ÁTMENETI	**7 nap**	↑	A fehérvérsejt szám 4,0 G/l, vagy annál kevesebb, vagy több, mint 10 G/l -t		#	
Határérték alatti hemoglobin érték	DL05	ÁTMENETI	**90 nap**	↑↓	Teljes vér adása esetén: nőknél kevesebb, mint 125 g/l; férfiaknál kevesebb mint 135 g/l Akiknek az elmúlt két évben -beleértve a jelenlegi mérést is- legalább 4 alkalommal mértek határérték alatti hemoglobin szintet, BV02 (anaemia gyanú) kóddal kell kizárni. Konvaleszcens plazma adásnál: nőknél 110 g/l; férfiaknál 115 g/l Vaspótlási programban részt vevő véradóknál a kiszűrési időre vonatkozóan lásd még: DON-14 utasítást.		#	**3650**
Határérték feletti hemoglobin érték	DL06	ÁTMENETI	**90 nap**	↑↓	Teljes vér adása esetén: nőknél több, mint 165 g/l; férfiaknál több mint 180 g/l Konvaleszcens plazma adásnál: mindkét nemnél több mint 170 g/l		#	**3651**
SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS EGYÉB KÜLSŐ OKOK KÖVETKEZMÉNYEI						**(BNO S00-T98)**		
Felületes sérülés	KS01	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓			#	
Csonttörés	KS02	ÁTMENETI	**60 nap**	↑↓			#	
Ficam	KS03	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓			#	
Égés, maródás, áramütés	KS04	ÁTMENETI	**30 nap**	↑↓			#	
Mérgezéses állapot vagy annak gyanúja	KM01	ÁTMENETI	**60 nap**	↑↓	Például: gomba-, étel-, nehézfém-, permetezőszer-, szerves oldószer mérgezés; mérges állatok csípése, marása. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.		#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Sugárbetegség	KH01	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a sugárbaleseteket. Terápiás izotópos kezelés esetén lásd: BE01 Daganat terápia céljából alkalmazott sugárkezelés esetén a daganat kódjával kell kiszűrni (BD kódok) Ízületi gyulladás, fájdalom miatt, gyulladáscsökkentő céllal kapott sugárkezelés nem kizáró ok.		###	
Napszúrás, egyéb hő és fényhatások	KH02	ÁTMENETI	**7 nap**	↑			#	
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOK, ANAMNESZTIKUS OKOK						**(BNO Z00-Z99)**		
Fertőző betegség kockázatának kitett személyek						**(BNO Z20-Z29)**		
Vérrel átvihető fertőzések megszerzésének fokozott kockázata	RF01	ÁTMENETI	**120 nap**	**Ø**	**Az a személy, aki négy hónapon belül szexuális kapcsolatot létesített kockázatos partnerrel** -prostituálttal; -szexuálisan kicsapongó életformát folytató személlyel; -injekciós kábítószert használó személlyel; -ismert, vagy gyanított HBV, HCV, HIV pozitív személlyel; -ismeretlen partnerrel, Kockázatos partner esetén akkor is kötelező a kizárás, ha óvszert használtak, illetve PrEP vagy PEP: HIV prevenció történt. Lásd gyógyszerlista. (Pre-Exposure Prophylaxis / Post-Exposure Prophylaxis) **Az a személy, aki négy hónapon belül biológiai expozíciót szenvedett:** Azok a személyek (ide értve elsősorban az egészségügyi dolgozókat), akiknek ismert HBV/HCV/HIV pozitív beteg vérével szennyezett tű vagy más éles eszköz okozott sérülést; a beteg vére sérült-, megrepedt-, kidörzsölt- gyulladt bőrfelülettel érintkezett, vagy a vér szem-, orr- vagy száj nyálkahártyára fröccsent. Amennyiben a személy Hepatitis- B elleni immunglobulin prevencióban is részesült: RF25 kiszűrést is alkalmazni kell. **Az a személy, aki négy hónapon belül fogvatartott volt büntetés végrehajtási intézetben, vagy vizsgálati fogságban.** **Az a személy, aki négy hónapon belül orrba szívható élvezeti szert használt másokkal közös eszközzel (p. feltekert papírpénz)**		###	**3668**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Kockázatos szexuális életvitel	RF28	TARTÓS	**végtelen**	↓	**Az a személy, aki fertőző betegségek megszerzéséhez nagy kockázattal járó szexuális életmódot folytat:** (nem elkülönítve a heteroszexuális és MSM kapcsolatot): • **Prostituált életmód:** Szexuális szolgáltatás nyújtott pénzért, kábítószerért, utazási kedvezményért, lakhatásért, vagy más anyagi ellenszolgáltatásért cserébe; • **Promiszkuis életmódot folytat:** Rendszeresen létesít szexuális kapcsolatot közvetített partnerekkel; ismeretlenekkel; szórakozóhelyi, alkalmi ismerősökkel; prostituáltakkal stb. • **Házastársi, élettársi kapcsolatban van kockázatos partnerrel:** -prostituálttal; -szexuálisan kicsapongó életformát folytató személlyel; -injekciós kábítószert használó személlyel; -ismert, vagy gyanított HBV, HCV, HIV pozitív személlyel; -vérzékeny beteggel, dializált beteggel (Octapharma követelmény); • **PrEP vagy PEP:** HIV prevenció céljából az elmúlt 180 napban antivirális kezelésben részesült **(**PrEP: Pre-Exposure Prophylaxis / Post-Exposure Prophylaxis) ***MAGYARÁZAT (a szabályzat vonatkozásában)****:* *Szexuális kapcsolat: vaginális, orális, vagy anális aktus.* *MSM (men who have sex with men): férfiak közötti szexuális kapcsolat függetlenül attól, hogy a résztvevőknek mi a nemi identitása és irányultsága*	**PrEP illetve PEP alkalmazása esetén a kiszűrési időt lásd a gyógyszerlistában.** **A többi kockázat esetén a kiszűrést a kockázati tényező megszűnése után egy évvel (365 nap), a kivizsgáló lezárhatja.**	#	**3678**
Állatharapás veszettség, vagy egyéb fertőzés fokozott kockázatával	RF02	ÁTMENETI	**365 nap**	**Ø**	Ha a harapás veszettségre gyanús vagy ismeretlen vagy vadon élő állattól, vagy trópusi országban történt. Ide értve a piócát, függetlenül attól, hogy a természetben, vagy természetgyógyászati kezelés során ejtett sebet a bőrön. *Veszettség kockázata esetén a kiszűrési idő akkor is egy év, ha a véradó a sérülést követően vakcinációban részesült.*		###	**3669**
Intravénás kábítószer, vagy recept nélküli injekció használata	RF03	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Ide sorolva a fekete kereskedelemben beszerzett iv. vagy im. alkalmazott testépítő szereket is. Intravénás kábítószer használatának gyanúja alapján is ki kell szűrni (pl. szúráshegek a könyökvénában)			
Fertőző beteggel közös háztartásban él	RF04	TARTÓS	**végtelen**	↓	TBC, HBV beteggel azonos családi házban, lakásban, szobában lakik. Gyermekbetegségek esetén: bárányhimlő, rubeola, kanyaró, stb. Lásd: RF42 A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni	A kockázati tényező megszűnése után, a lappangási idő figyelembevételével lezárható.	#	
Kontaktus ragályos fertőző beteggel	RF42	ÁTMENETI	**21 nap**	↑	A kiszűrést a kontaktus napjával kell indítani. Ide sorolva: övsömör, kanyaró, rubeola, mumpsz, varicella, majomhimlő (mpox), MPOX esetén a kizárást fel kell emelni 30 napra. Diagnosztizált megbetegedés esetén lásd: FK02, FK05, FA13		#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Trópusi betegség átvitelének kockázata	RF05	ÁTMENETI	**180 nap**	**Ø**	Azok a személyek, akik az elmúlt egy év során 24 óránál hosszabb, de 6 hónapnál rövidebb ideig, tartózkodtak összefüggően trópusi országban és onnan tünetmentesen tértek vissza. *Lásd: DON01_A08 malária és/vagy Chagas-betegség szempontjából kockázatos országok.* *Az érintett ország nevét kötelező az orvosi megjegyzésekben feltüntetni* *A kiszűrés kezdete az endémiás országból való visszatérés napja.* *A kemoprofilaxis (pl. Delagil <chloroquin>, Lariam <mefloquin>) illetve antibiotikus kezelés (pl. Doxycylin) nem ad tökéletes biztonságot, tehát nem mentesíti a véradót a kiszűrés alól.* *A véradót meg kell kérni, hogy következő jelentkezésekor jelezze, ha a 180 napos kiszűrés alatt belázasodott (malária gyanú) lásd: RF35*		#	**3670**
Trópusi betegség átvitelének kiemelt kockázata	RF06	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva azok a személyek, akik malária és/vagy Chagas-betegség szempontjából kockázatos országban transzfúziót kaptak. *(Kockázatos országok listáját lásd: DON01_A08.)* *Igazolt Malária, Leishmaniasis, Chagas-betegség, Babesiosis esetén lásd: FP01, FP02, FP03, FP05* *Malária és/vagy Chagas beteség hordozásának kockázata esetén lásd: RF35 és/vagy RF36*	*Trópusi országban kapott transzfúzió esetén a kiszűrés nem lezárható.*	#	**3671**
Malária hordozásának kockázata	RF35	TARTÓS	**végtelen**	↓	Azok a személyek akiknek életük során, maláriás országban való tartózkodásuk alatt, vagy onnan való visszatérésük után 6 hónapon belül **diagnosztizálatlan magas lázuk volt**. *Igazolt malária esetén lásd: FP01* Azok a személyek, **akik malária endémiás országban születtek;** vagy akik életük során **6 hónapnál hosszabb ideig tartózkodtak összefüggően maláriás országban.** (tünetmentes malária lehetősége). Negatív eredményű malária ellenanyag vizsgálattal rendelkező véradót csak akkor kell kizárni, ha az ellenanyag vizsgálatot követően maláriás területen újabb látogatást tesz. *Lásd: DON01_A08 malária szempontjából kockázatos országok* *Az érintett ország nevét kötelező az orvosi megjegyzésekben feltüntetni* *Amennyiben releváns, az RF36 kiszűrést párhuzamosan alkalmazni kell.*	*A kiszűrés lezárható, ha a **gyógyulást/maláriás területről való visszatérést követő legalább 180 nap múlva**, az OVSz laboratóriumban végzett **malária ellenanyag** vizsgálat eredménye negatív.* *Külső laboratóriumban végzett vérkenet, antigén vagy NAT eredménye, továbbá az otthon elvégezhető, önvizsgálatra használt gyorstesztek negatív eredménye (POC teszt) nem elfogadható.* ***A vizsgálatra időszakosan kerül sor, melyről a véradót levélben értesítjük.***	##	**3680**

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Chagas-betegség hordozásának kockázata	RF36	TARTÓS	**végtelen**	↓	Azok a személyek, **akik Chagas-betegség endémiás országban születtek**, vagy életük során **6 összefüggő hónapnál hosszabb ideig ott éltek.** *Lásd: DON01_A08 Chagas-betegség szempontjából kockázatos országok* *Az érintett ország nevét kötelező az orvosi megjegyzésekben feltüntetni* *Amennyiben releváns, az RF35 kiszűrést párhuzamosan alkalmazni kell.*	*Jelenleg szűrővizsgálat nem áll rendelkezésre* *Amennyiben a vizsgálat beállításra kerül, a véradót levélben értesítjük.*	##	**3681**
Epidemiológiai kockázat miatt (külön megnevezés nélkül)	RF07	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Azok a személyek, akik vírusos lázak szempontjából **nem nyomon követett országban** 24 óránál hosszabb ideig tartózkodtak összefüggően (DON01_A08 táblázat). *A kiszűrés kezdete a kockázatos terület elhagyásának napja.* Azok a személyek, akik vírusos lázak szempontjából **időlegesen kockázatosnak minősített országban** 24 óránál hosszabb ideig tartózkodtak összefüggően, (DON01_A08_EPAlarm táblázat aktuális verzió) *A kiszűrés kezdete a kockázatos terület elhagyásának napja.* Ide sorolva a külön kóddal nem jelölt fertőző betegségek: pl. O' nyong-nyong láz, Venezuelai ló-láz, Rift Valley láz *Sárgaláz stb.* ***Megjegyzés:*** *WNV kockázat miatt lásd: RF38* *Dengue kockázat miatt lásd: RF39* *Chikungunya kockázat miatt lásd: RF40* *Zika kockázat miatt lásd: RF 41* Azok a személyek, akik az elmúlt 30 nap során valamilyen csíkos szúnyogtól (például ázsiai tigrisszúnyog, egyiptomi szúnyog, japán bozótszúnyog, koreai szúnyog stb.) csípést szenvedtek. *A kiszűrés kezdete a csípés időpontja*		#	**3672**
WNV kockázat miatt	RF38	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Azok a személyek, akik WNV szempontjából **időlegesen kockázatosnak minősített országban** 24 óránál hosszabb ideig tartózkodtak összefüggően, (DON01_A08_EPAlarm táblázat aktuális verzió) *A kiszűrés kezdete a kockázatos terület elhagyásának napja.* *Megjegyzés:* *A kiszűrést az EPAlarm táblázat csak a WNV szezonon kívüli esetben írja elő (WNV szezonban minden donor esetében WNV NAT vizsgálat történik)*		#	
Dengue vírus kockázat miatt	RF39	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Azok a személyek, akik Dengue vírus szempontjából **időlegesen kockázatosnak minősített országban** 24 óránál hosszabb ideig tartózkodtak összefüggően, (DON01_A08_EPAalarm táblázat aktuális verzió) *A kiszűrés kezdete a kockázatos terület elhagyásának napja.*		#	
Chikungunya vírus kockázat miatt	RF40	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Azok a személyek, akik Chikungunya vírus szempontjából **időlegesen kockázatosnak minősített országban** 24 óránál hosszabb ideig tartózkodtak összefüggően, (DON01_A08_EPAlarm táblázat aktuális verzió) *A kiszűrés kezdete a kockázatos terület elhagyásának napja.*		#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Zika vírus kockázat miatt lásd	RF41	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Azok a személyek, akik Zika vírus szempontjából **időlegesen kockázatosnak minősített országban** 24 óránál hosszabb ideig tartózkodtak összefüggően, (DON01_A08_EPAlarm táblázat aktuális verzió) *A kiszűrés kezdete a kockázatos terület elhagyásának napja.*		#	
Kullancscsípést követően	RF08	ÁTMENETI	**30 nap**	↑			#	**3673**
TSE szempontjából kockázatos esemény	RF09	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**	Átvihető szivacsos agysorvadás (Transmissible Spongiform Encephalopathies) veszélye, például: Creutzfeldt-Jakob-kór; vCJD. Idesorolva azok a személyek, akiknek családi anamnézisében CJD előfordult, továbbá azok a személyek, akik szaruhártya vagy kemény agyhártya transzplantátumot kaptak, vagy emberi agyalapi mirigyből készült gyógyszerekkel kezelték őket.		###	
Nem igazoltan steril tűvel kezelték	RF10	ÁTMENETI	**120 nap**	**Ø**	Ide sorolva azok a személyek, akiknél az alábbi beavatkozásokat végezték: • fülcimpa-lyukasztás, testékszer felhelyezés; • tetoválás, *ide értve a tartós sminket és a microbladig technikát, valamint a tetoválás felfrissítését („átütés") is;* • a bőr megsértésével végzett fiatalító eljárás, *például a dermaroller nevű tűs görgő alkalmazása.* Intravénás kábítószer fogyasztó esetén lásd: RF03		###	**3674**
Akupunktúrás kezelést kaptak.	RF37	ÁTMENETI	**120 nap**	**Ø**	A kizárást az utolsó kezeléstől kell indítani. Folyamatban lévő kezelés esetén mindig az utolsó kezeléstől számított 120 napra kell kiszűrni Folyamatban lévő kezelés esetén az első kezelés időpontját a megjegyzésekhez rögzíteni kell.		###	
Élő, attenuált oltóanyagot kapott	RF11	ÁTMENETI	**30 nap**	↑	Ide sorolva azokat a személyeket, akiknek vakcinációja attenuált vírusokkal vagy baktériumokkal történt (pl.: **BCG, sárgaláz, rubeola, kanyaró, mumps)** Szintén ezzel a kategóriával kell kizárni azokat, akik esetében nem állapítható meg teljes biztonsággal az oltóanyag típusa (pl. külföldi vakcinácó esetén). A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. *Panaszmentesség és expozíció hiánya esetén nem kizáró ok az alábbi oltóanyagokkal történő vakcináció:* • *inaktvált/elölt vírusok, baktériumok vagy rikettsiák;* • *toxoidok,* • *fehérjealegység (pl. rekombináns antigén) alapú oltóanyagok,* • *génbázisú (pl. mRNS alapú) oltóanyagok,* • *nem replikálódó vektor alapú oltóanyagok.* *pl.: influenza; poliomyelitis-ina; elölt typhus; elölt cholera; hepatitis-A; kullancs encephalitis; COVID-19 vakcina* *Oltási panaszok esetén lásd: DT12* ***Kivéve a HBV elleni védőoltás lásd: RF24 !!***		#	**3675**
Állati szérumot kapott	RF12	ÁTMENETI	**90 nap**	**Ø**			#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Transzfúziót kapott	RF13	ÁTMENETI	**120 nap**	**Ø**	Labilis vérkészítmény kapott (vvs. thr. plazma) Külön kategóriába sorolva azok a személyek, akik az Egyesült királyságban kaptak transzfúziót lásd RF 27. Külön kategóriába sorolva azok a személyek, akik trópusi országban való tartózkodásuk alatt kaptak transzfúziót lásd RF06		###	
Stabil vérkészítményt kapott	RF14	ÁTMENETI	**30 nap**	**Ø**	Gyári vérkészítményt kapott. (pl: albumin, gamma-globulin. immunglobulin) Külön kategóriába sorolva a prevenció céljából adott Hepatitis B elleni immunglobulin, lásd RF25		#	
Xenotranszplantátum recipiens	RF15	VÉGLEGES	**végtelen**	**Ø**			###	
Iatrogén fertőzés kockázatának volt kitéve	RF16	ÁTMENETI	**120 nap**	**Ø**	Azok a személyek, akiknél rugalmas eszközzel endoszkópos vizsgálat történt.		###	**3676**
Huzamosan az Egyesült Királyságban élt	RF23	TARTÓS	**végtelen**	↓	Azok a személyek, akik 1980 és 1996 között összefüggően legalább egy évet az Egyesült Királyságban éltek (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales) *A kiszűrés a frakcionáló üzem követelménye CJD átvitel kockázata miatt.*		###	**3677**
HBV elleni védőoltást kapott	RF24	ÁTMENETI	**30 nap**	**Ø**	Azok az egészséges személyek, akiknél a védőoltás a későbbi fertőzés kivédése érdekében történik pl. ENGERIX TWINRIX részletesen (OVSz/ DON06).. A kiszűrés oka az, hogy az oltás következményeként a HBsAg vizsgálat pozitív eredményt ad. Amennyiben a véradó nem közli az oltás tényét, és a HBV szűrővizsgálat eredménye FB70 (konfirmált pozitív), **a kiszűrés későbbi negatív vizsgálati eredményekkel nem írható felül!** **A kiszűrés kezdő dátuma az oltás időpontja.** *Oltási sorozatnál az aktuálisan utolsó oltást kell figyelembe venni.* HBV fertőzés kockázata esetén (pl. tűszúrásos baleset) lásd RF01 vagy RF 25.		#	
Expozíciót követő Hepatitis B immunglobulin prevenció	RF25	ÁTMENETI	**180 nap**	**Ø**	HBV átvitel kockázatával járó biológiai expozíciót (pl tűszúrásos balesetet követő pl. HIBIG oltás (OVSz/ DON06).. **A EXPOZÍCIÓ IDŐPONTJÁT A MEGJEGYZÉS ROVATBAN RÖGZÍTENI KELL** *A kiszűrés oka, hogy a passzív védőoltás nem nyújt teljes védelmet a fertőzéssel szemben.* Amennyiben az expozíciót nem követte preventív oltás, lásd: RF01		###	
Az Egyesült Királyságban kapott transzfúziót	RF27	TARTÓS	**végtelen**	↓	Kockázat nélküli transzfúzó esetén: RF13 Trópusi országban való tartózkodásuk alatt kaptak transzfúzió esetén: RF06 *A kiszűrés a frakcionáló üzem követelménye CJD átvitel kockázata miatt.*		###	
Vércsoport nem meghatározható rutin vércsoport-szerológiai módszerrel	RF31	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva azokat a donorokat, akiknél a Donor Vércsoportszerológiai Laboratórium legalább két alkalommal: • diszkrepanciát tapasztal, vagy • nem meghatározható eredményre jut.		###	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Külföldi első véradó	RF32	ÁTMENETI	**180 nap**	**Ø**	Az *e*Progesában korábban nem szerepelő (első véradók) a DON01 szabályai szerint „8" („V előzetes minta") vérvételi típussal kerülnek felvételre. *Az esemény véglegesítésekor az eProgesa rendszer az RF32 kiszűrést automatikusan rögzíti.* **RF32 kiszűrés alatt csak mintavétel végezhető!**		###	
Vércsoport szerológiai ok						**(BNO R77)**		
DAT pozitivitás (3+, 4+)	RF19	TARTÓS	**végtelen**	↓	A donor DAT 3+ vagy 4+ pozitív. A donort szakorvoshoz kell irányítani.	A kiszűrés szakorvosi lelet alapján lezárható.	#	
DAT pozitivitás (1+, 2+)	RF33	ÁTMENETI	**35 nap**	**Ø**	A DAT 1+ és 2+ pozitívak eredményükről tájékoztató levelet kapnak, szakorvoshoz való irányításuk nem indokolt. *A kiszűrés a következő véradásra automatikusan lezáródik.*		#	
Születéskori nemét okmányaiban megváltoztatták	RF34	TARTÓS	**végtelen**	↓	Nemi átalakító műtét esetén lásd: RA12 *A nemi hormonkezelés nem kizáró ok.* A kizárás oka a nemhez kötött kötelező irreguláris vércsoport ellenanyag vizsgálati algoritmus kezelhetetlensége. Nem megvalósítható ugyanis a recipiensekben kialakuló súlyos tüdő szövődmény (TRALI) kivédésének érdekében a női donoroktól származó FFP közvetlen transzfúziós felhasználását tiltó szabály alkalmazása. A nemhez kötött elfogadási paraméterek pl. hemoglobin szint, véradási szám kezelhetetlensége.		###	
Munkával, sporttal kapcsolatos kockázatok						**(BNO Z57)**		
Veszélyes foglalkozás, vagy sport	RM01	ÁTMENETI	**aznap**	**Ø**	Veszélyes foglalkozást, vagy veszélyes sportot űző személyek, a tevékenység megkezdése előtt 12 órával ne adjanak vért.		#	
Kockázatok a személyes anamnézisben						**(BNO Z80-Z99)**		
Orvosi kivizsgálás	RA25	ÁTMENETI	**180 nap**	↑↓	**Várakozás kivizsgálásra vagy eredményre:** olyan állapot miatt, melynek diagnózisa kiszűréshez vezethet, például: prosztata-, gyomorfekély-, kövek-, ciszták-, mellcsomó, trombophilia, daganat kivizsgálása stb. Ide sorolva azok az esetek, amikor a kivizsgáló által gyanított megbetegedés miatt **a donort szakorvoshoz irányítja**: pl.: *Leishmaniasis-, Babesiosis, Q-láz, Brucellosis, vírusos lázak stb.* *Nem kizáró ok az alábbi vizsgálatokra való várakozás:* • *nem kizáró betegség gyanúja miatt készülő laboratóriumi vizsgálat,* • *rutin szűrővizsgálat például: méhnyak kenet, mammográfiás vizsgálat;* • *nem kizáró vagy kontrollált/karbantartott betegség rutinszerű monitorozása, például: ismert cukorbetegség, pajzsmirigy betegség, magas vérnyomás stb.* A vizsgálat irányát, a betegség gyanúját kötelező az orvosi megjegyzések közé beírni.	Bemutatott negatív lelet alapján a kiszűrés lezárható, az alábbi feltételekkel: • amennyiben a vizsgálat során kontrasztanyagot használtak, és még releváns, akkor a vizsgálat kezdő napjával ki kell szűrni RA26 kóddal. • amennyiben endoszkópos vizsgálat történt, és még releváns, akkor a vizsgálat kezdő napjával ki kell szűrni: RF16 Diagnosztizált betegség esetén a kiszűrés lezárható, és helyette a betegségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.	#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Kontrasztanyaggal végzett vizsgálat	RA26	ÁTMENETI	**180 nap**	↑↓	Függetlenül a vizsgálat negatív eredményétől, kontrasztanyag használata esetén, a vizsgálat időpontjától kezdődően a kizárás: • izotópos (radionuklid) kontrasztanyag esetén 180 nap; • iv. alkalmazott nem izotópos kontrasztanyag esetén (pl MR vizsgálatok) 14. nap; • per os v. rektálisan alkalmazott, nem izotópos kontrasztanyag (pl. bárium szulfát) esetén 7. nap.		#	
Terhesség, szülés, megszakadt terhesség	RA01	ÁTMENETI	**180 nap**	↑↓	Szülést-, vetélést-, terhesség megszakítást követően. A terheseket a szülés várható időtartamát követő fél évig (180 nap) kell kiszűrni. A szoptatás önmagában nem kizáró ok, azonban javasolható, hogy a szoptatás intenzív szakaszában (amikor a gyerek fő tápláléka az anyatej) lehetőleg ne adjon vért az anya.		#	
Anamnézisben anafilaxia vagy nagyfokú túlérzékenység	RA05	TARTÓS	**végtelen**	↓	Ide sorolva, akiknek az **elmúlt két hétben** –kiváltó ágenstől függetlenül- nagyfokú túlérzékenységi (anafilaxiás) reakciója volt. Ide sorolva azokat, akik a vérvétel során szóba jöhető kémiai anyaggal szembeni nagyfokú túlérzékenységet mutatnak (pl.: bőrfertőtlenítő szer). A túlérzékenységet okozó anyag megnevezését az orvosi megjegyzésben rögzíteni kell. Allergiás rhinitis, szénanátha esetén lásd: BL05 Allergiás conjunctivitis lásd: BS04 Allergiás bőrtünetek (urticria): DT09	Az anamnézisben szereplő nagyfokú túlérzékenységi reakció esetén, az eseményt (kezelést) követő két hét múlva, a kiszűrés lezárható. A korábbi szabályozás alapján anafilaxia miatt kiszűr véradók visszavehetők, amennyiben a túlérzékenységet kiváltó anyaggal való kontaktus nem jö szóba a véradás helyszínén. *A szabályváltozás alapja: Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components 21st Edition / EDQM April 2023 / 2.3.2.3. Allergy and anaphylaxis* Az élete során előforduló anafilaxiás reakciót jelölni kell az orvosi kérdőíven! A bőrfertőtlenítő szerrel szembeni allergia esetén a kiszűrés a szer váltása esetén lezárható.	#	**3662**
Nagyfokú mozgáskorlátozottság	RA06	VÉGLEGES	**végtelen**	Ø	Például mindkét alsó végtag hiánya. Mozgásában korlátozott személy akkor adhat vért, ha kis segítséggel át tud ülni a vérvételi ágyra. *Megjegyzés: Kerekes székben ülő személytől nem szabad vért venni, mert ájulásos rosszullét esetén nem lehetséges a megfelelő ellátás.*		###	
Felső végtag hiánya	RA07	VÉGLEGES	**végtelen**	Ø	*Megjegyzés: A kiszűrést az indokolja, hogy vérvétel során az ép felső végtagot érintő esetleges szövődmény miatt ne következhessen be jelentős romlás a véradó életvitelében*		###	
Belső szerv hiánya, vagy részleges elvesztése	RA08	VÉGLEGES	**végtelen**	Ø	Ide sorolva például a lép szerzett hiányát, vagy a máj részleges elvesztését. Egészséges, egy vesével normális életet élő személy esetén, (pl. veleszületett hiány, szervdonor, baleset miatt elvesztett) esetén amennyiben a tumor, autoimmun betegség kizárható, a kivizsgáló megítélése szerint adhat vért		###	
Hypotenzív szövődmény az anamnézisben	RA09	TARTÓS	**végtelen**	↓	A véradó bejelenti, vagy véradás előtt beszámol arról, hogy többszöri vagy jelentős hypotenziv szövődménye volt korábbi véradáskor, vagy a véradási helyszín elhagyását követően. A kiszűrést az eseményhez képest 10 napos késleltetett dátummal kell kezdeni *(pl. jan. 10.-i rosszullét esetén a kiszűrés jan. 20.-n indul.)*	Legalább egy év elteltével, a kivizsgáló megítélése szerint lezárható	#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Véralvadásgátló gyógyszer szedése („vérhígítók”)	RA10	TARTÓS	**végtelen**	↓	Nem ide sorolva a trombocita aggregáció gátlókat. Párhuzamosan alkalmazható más kiszűrési kódokkal (pl. betegség, műtét).	A preventív céllal alkalmazott heparin, heparin származék és K-vitamin antagonista esetén (pl.: warfarin, acenocoumarol Syncumar), amennyiben az alapbetegség miatt lehetséges, a kiszűrés a kezelés befejezését követően egy hét múlva lezárható.	#	**3663**
Teratogén kockázatú gyógyszer szedése	RA11	TARTÓS	**végtelen**	↓	A figyelembe veendő gyógyszereket lásd az OVSz aktuális gyógyszerlistájában (OVSz/ DON06). Kiszűrés esetén az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni a gyógyszer nevét.	A gyógyszer listában megadott időkorlát letelte után a fennálló kiszűrés lezárható.	#	**3664**
Nagy műtéti beavatkozás	RA12	ÁTMENETI	**120 nap**	↑			###	**3665**
Szívműtét	RA13	VÉGLEGES	**végtelen**	Ø	Kivéve a műtéttel korrigált teljesen gyógyult veleszületett rendellenességeket. Lásd még: RA12		###	
Kisebb műtéti beavatkozás és egyéb invazív orvosi kezelés	RA14	ÁTMENETI	**90 nap**	↓	Testüregbe nem hatoló kis műtétek, pl. bőrgyógyászati beavatkozások (pl.: égetés, fagyasztás, szkleroterápia, lézeres kezelés stb.); szürkehályog-műtét stb. esetén a beavatkozás jellegének megfelelően a kivizsgáló rövidítheti a kiszűrési időt.	A kiszűrés legkorábban a gyógyulást követő két hét múlva zárható le. *A lezárás feltétele, hogy a seb tökéletesen legyen gyógyult, az esetleges varratok legyenek eltávolítva, a kezeléssel összefüggésben alkalmazott terápia legyen befejezve.*	#	**3666**
Kisebb fogászati kezelés	RA15	ÁTMENETI	**1 nap**	↑	A kezelés napján, és a rákövetkező napon nem adhat vért.		#	
Foghúzás, gyökérkezelés	RA16	ÁTMENETI	**14 nap**	↑	Ide értve a fogászati beavatkozás során alkalmazott csontgraftot és az implantátum beültetést is.		#	**3667**
Szervátültetésen esett át	RA17	VÉGLEGES	**végtelen**	Ø	Emberi eredetű sejt/szövet transzplantáció. Transzfúzió esetén lásd: RF13 Xenotranszplantátum esetén lásd: RF15		###	
Sikertelen retranszfúzió	RA18	ÁTMENETI	**55 nap**	Ø	Amennyiben a vörösvérsejt retranszfúzió sikertelenvolt.		###	
Véradó nyilatkozata alapján (meg nem nevezett kockázati tényező)	RA20	TARTÓS	**végtelen**	↓	**Ide sorolva azt a helyzetet, ha a véradó a kikérdezés során nem kíván valamelyik kérdésre válaszolni, vagy utólagosan bejelenti, hogy indoklás nélkül visszavonja egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozatát (PDI).** A donor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a kivizsálás során a bizonylaton átjavítja a „vérem gyógyító célra felhasználható” kérdésre adott válaszát NEM–re. Ebben az esetben az orvosi kérdőívbe a *„nyilatkozatát véradás előtt visszavonta”* megjegyzést kell tenni.	Amennyiben a véradó későbbi jelentkezésekor ésszerű és a kivizsgáló számára elfogadható magyarázatot ad viselkedésére, a kiszűrés lezárható. **A visszavétel magyarázatát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.**	#	
Sikertelen vérvétel	RA21	ÁTMENETI	**55 nap**	Ø	1 ml és 404 ml közötti vérvétel esetén		#	
Aktivált össejtdonor	RA22	ÁTMENETI	**180 nap**	↑↓		A kiszűrést a Magyar Csontvelődonor Regiszter munkatársa szüntetheti meg.	##	
Össejt donációt követően	RA23	ÁTMENETI	**365**	Ø			###	
BactAllert® riasztás	RA27	TARTÓS	**végtelen**	↓	Azokban az esetekben, amikor a BactAllert® készülék előzetes riasztást ad, felmerül a donornál a bakterémia kockázata	A baktérium identifikálása után, az eredmény függvényében az MBI zárhatja le.	#	
Donor PDI bejelentése betegségről k.m.n.	RA28	TARTÓS	**végtelen**	↓	Azokban az esetekben, amikor a véradó telefonon, vagy levélben jelenti be alkalmatlanságát, de nem közölte, vagy nem egyértelműen azonosítható a betegség. A levelet rögzíteni kell a donor személyi lapjához.	A személyesen jelentkező véradóval való találkozás során a kivizsgáló (figyelembe véve a kizáráskor alkalmazott orvosi megjegyzést és a csatolt levelezést) belátása szerint lezárhatja.	#	
EGYÉB KISZŰRÉSI OKOK								
Egyéb kiszűrési ok	XX00	TARTÓS	**végtelen**	↓	Máshova nem sorolható kizáró ok esetén **Nyomatékos figyelmeztetés a kivizsgálónak:** **A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni.** A jelen táblázatban tételesen nem szereplő fertőző betegség esetén lásd: FX99 A donor által jelentett PDI k.m.n. lásd RA28	Amennyiben a megjegyzésrovat nem tartalmazza a kiszűrés okát, vagy a kizáró ok megszűnik, a kiszűrés a kivizsgáló megítéléae szerint lezárható, a vér levehető. (Nem szükséges előzetes mintavétel)	#	

MEGNEVEZÉS	KÓD	TÍPUS	ALAP ÉRT	MÓD	MEGJEGYZÉS	LEZÁRÁS		levél
Kiszűrés aferezisből egyéb ok miatt	XX03	TARTÓS	**végtelen**	↓	Kizárólag „Q” vérvételi típusra vonatkozó kiszűrés.	A kiszűrést csak a szakmai főigazgató-helyettese zárhatja le.	##	
Plazmaferezis állomás jelentése alapján	XX06	TARTÓS	**végtelen**	↓	A plazmaferezis állomás a véradó végleges kiszűrését jelentette k.m.n. HIV/HBV/HCV *Nevesített: HBV / HCV / HIV jelentése esetén lásd: FB60 /FC60 /FH 60*	A kiszűrés lezárása megszüntetése nem kezdeményezhető! Amennyiben a kiszűrés az OctaPharma felé PDI-t generál, akkor előírásra kerül a „$” mintavétel. Amennyiben ennek előírt vizsgálatai megtörténnek, az eredményének megfelelően a kiszűrés módosul.	###	**3682**
Ipari célú mintaadás felfüggesztve	XX08	TARTÓS	**végtelen**	↓		A kiszűrés lezárása a DON-05_A04 utasítás szerint történik.	#	
Trombocita-ferezisre átmenetileg alkalmatlan	XX09	ÁTMENETI	**14 nap**	↑↓	Ide sorolva például ha a trombocita donor aggregációt gátló gyógyszert szed. A kiszűrés okát az orvosi megjegyzés rovatban meg kell adni. A kiszűrés csak a trombocita donorokra vonatkozik.	A kiszűrés a gyógyszer szedésének befejezésétől számított két hét múlva (14 nap) lezárható.	#	
Informatikai rendezés alatt	XX10	TARTÓS	**végtelen**	↓	A kiszűrés a központilag kezelt közepes és magas kompetencia szintű kiszűrések visszavonásakor kerül átmenetileg a véradóra. A kiszűrést kizárólag a magas kompetencia megszüntetésére jogosult személy alkalmazhatja. **Tilos a kiszűrést vérellátóban alkalmazni!**	A kiszűrést az informatikai rendezés során a vérellátóban kell lezárni.	#	
A véradó elhalálozott	XX99	VÉGLEGES	**végtelen**	Ø	Hozzátartozók vagy hatóság által bemutatott vagy megküldött halotti anyakönyvi kivonat. A dokumentum azonosítási adatait, vagy a szkennelt másolatát a véradó személyi lapjához csatolni kell.		#	

KÓD-VISSZAKERESÉSI TÁBLÁZAT

BB01	Bőrelváltozások, sebek		
BB02	Psoriasis		
BC01	Rheumatoid arthritis		
BC02	Egyéb izületi betegség		
BC03	Autoimmun betegség		
BC04	Ischias		
BC05	Súlyos osteoporosis		
BC06	Osteomyelitis		
BC07	Egyéb csontrendellenességek		
BD01	Rosszindulatú daganat		
BD02	Nyirok és vérképző szervek daganata		
BD03	Ismeretlen természetű daganat		
BD04	Lymphoma és a leukemia.		
BE01	Pajzsmirigy betegség		
BE02	Cukorbetegség		
BE03	Egyéb endocrin rendellenesség		
BE04	Anyagcsere rendellenesség		
BE05	Haemochromatosis		
BE06	Hashimoto-thyreoiditis		
BF01	Külsőfül-betegség		
BF02	Középfül-betegség		
BF03	Belsőfül-betegség		
BF04	Kommunikációt zavaró süketség		
BG01	Gyomor-, nyombél fekély		
BG02	Crohn-betegség		
BG03	Colitis ulcerosa		
BG04	Idült nem fertőző májbetegség		
BG05	A hasnyálmirigy betegsége		
BG06	Az emésztőrendszer egyéb betegsége		
BI01	Parkinson-kór		
BI02	Epilepsia		
BI03	A központi idegrendszer egyéb betegsége		
BI04	Sclerosis multiplex		
BK01	Rheumás láz a szív érintettsége nélkül		
BK02	Rheumás szívbetegség		
BK03	Angina pectoris		
BK04	Szívinfarktus		
BK05	Heveny szívbelhártya- illetve szívburok gyulladás		
BK06	Heveny szívizomgyulladás		
BK07	Szívritmuszavar		
BK08	Szívelégtelenség		
BK09	Cerebrovascularis betegség		
BK10	Atherosclerosis		
BK11	~~Artériás embolia és thrombosis~~ Thrombophilia és thrombophilia eredetű thrombosis és embólia		
BK12	~~Vénás embolia és thrombosis~~ Trombózis és embólia		
BK13	Viszérgyulladás és felületes vénás trombózis		
BK14	Magasvérnyomás betegség		
BL01	Nátha	INAKT	#
BL02	Heveny melléküreg gyulladás	INAKT	#
BL03	Felső légúti fertőzés		
BL04	Influenza ~~és tüdőgyulladás~~ és influenzához hasonló megbetegedés		
BL05	Allergiás rhinitis		
BL06	Aktív súlyos bronchitis		
BL07	Asthma bronchiale		
BL08	Idült légzési elégtelenség		
BL09	Kórházi ellátást igénylő COVID-19		
BL10	Tüdőgyulladás		
BM01	Alkoholos állapot vagy tudatmódosító szer		
BM02	Alkoholizmus		
BM03	Drog, pszichoaktív anyag rendsz. haszn.		
BM04	Súlyos mentális elmaradottság		
BM05	Mentális rendellenesség		
BM06	Schizophrenia		
BR01	Vénahiány a vérvételi helyen		
BS01	Nem fertőző súlyos szembetegségek		
BS02	Zöldhályog (glaucoma)		
BS03	Egyéb szembetegség		
BS04	Fertőző vagy gyulladásos szembetegség		
BU01	Akut glomerulonephritis		
BU02	Krónikus vesebetegség		
BU03	Húgyhólyag-gyulladás		
BU04	Férfi nemi szervek gyulladásos betegsége		
BU05	A női medence gyulladása		
BV01	β-thalassaemia		
BV02	Anaemia gyanú, vagy ismételten alacsony hemoglbin szint		
BV03	Hemofília		
BV04	Egyéb vérképzőszervi betegség, vagy pontosan meg nem határozott véralvadási zavar,		
BV05	Immunrendszert érintő rendellenesség		
BV06	Polycythaemia rubra vera		
DL01	Határértéken kívüli hemoglobin érték	INAKT	#
DL02	Határértéken kívüli fehérvérsejt szám		
DL03	Határértéken kívüli trombocita szám		
DL04	Határértéken kívüli plazmafehérje szint		
DL05	Határérték alatti hemoglobin érték		
DL06	Határérték feletti hemoglobin érték		
DS01	HBsAg csak szűrővizsgálatban reaktív	INAKT	##
DS02	anti-HCV csak szűrővizsgálatban reaktív	INAKT	##
DS03	anti-HIV csak szűrővizsgálatban reaktív	INAKT	##
DS04	anti-TP csak szűrővizsgálatban reaktív	INAKT	##
DS05	Ismételten csak szűrővizsgálatban reaktív	INAKT	##
DS06	Konfirmálással nem igazolt reaktivitás	INAKT	##
DT01	A szívverés rendellenessége (EKG nélkül)		
DT02	~~Szívzörej~~ Szívbetegségre utaló tünet		
DT03	Magas vérnyomás (diagnózis nélkül)		
DT04	Alacsony vérnyomás (diagnózis nélkül)		
DT05	Nehézlégzés		
DT06	Máj megnagyobbodás		
DT07	Lép megnagyobbodás		
DT08	Sárgaság		
DT09	Bőrtünetek		
DT10	Magatartással kapcsolatos eltérések		
DT11	Lázas állapot (diagnózis nélkül)		
DT12	Rossz közérzet		
DT13	Ismeretlen eredetű eszméletvesztés		
DT14	Nyirokcsomó megnagyobbodás		
DT15	Súlyhatár alatti donor		
DT16	Eritrocita ferezishez túl alacsony testmagasság		
DT17	Súlyhatár feletti donor		
EXIT	A véradó elhalálozott	INAKT	#
FA01	HAV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FA13	HAV OVSz vizsgálat nélkül pozitív		
FA21	HAV NAT pozitív	INAKT	##
FA33	HAV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FA70	HAV NAT pozitív		
FB01	HBV konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FB02	HBV konfirmálás folyamatban	INAKT	##
FB03	anti-HBc szűrővizsgálatban reaktív	INAKT	##
FB04	HBV automatikus kizárás	INAKT	##
FB05	HBsAg szűrővizsgálat ismételten reaktív	INAKT	##
FB06	Negatív HBV konfirmálást követő kizárás	INAKT	##
FB09	HBV visszahívás eredménytelen	INAKT	##
FB13	HBV OVSz vizsgálat nélkül pozitív		
FB21	HBV véradási minta NAT reaktív	INAKT	##
FB22	anti-HBc véradási minta szűrő reaktív	INAKT	##
FB23	HBV véradási minta automatikusan pozitív	INAKT	##
FB30	HBV konfirmálás folyamatban		
FB31	HBV véradási minta konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FB33	HBV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FB40	HBV konfirmálás második mintára vár	INAKT	##
FB41	HBV két mintából konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FB42	HBV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	INAKT	##
FB46	anti HBc reaktív, fertőzés nem konfirmálható	INAKT	##
FB47	HBV konfirmált negatív		
FB48	HBV- nem igazolt szűrő reaktivitás		
FB51	HBV visszavezetés		
FB60	HBV plazmaferezis állomás jelentette pozitív		
FB70	HBV pozitív		
FB85	anti-HBc reaktív		
FB90	HBV technikai ok miatt nem meghatározható		
FC01	HCV konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FC02	HCV konfirmálás folyamatban	INAKT	##
FC05	HCV szűrővizsgálatban ismételten reaktív	INAKT	##
FC06	Negatív HCV konfirmálást követő kizárás	INAKT	##
FC08	HCV reaktív, fertőzés nem konfirmálható	INAKT	##
FC09	HCV visszahívás eredménytelen	INAKT	##
FC13	HCV OVSz vizsgálat nélkül pozitív		
FC21	HCV véradási minta NAT reaktív	INAKT	##
FC30	HCV konfirmálása folyamatban		
FC31	HCV véradási minta konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FC33	HCV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FC39	HCV kétes második mintára vár	INAKT	##
FC40	HCV konfirmálás második mintára vár	INAKT	##
FC41	HCV két mintából konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FC42	HCV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	INAKT	##

FC43	HCV reaktív, fertőzés nem konfirmálható	INAKT	##
FC47	HCV konfirmált negatív		
FC48	HCV nem igazolt szűrő reaktivitás		
FC51	HCV visszavezetés		
FC60	HCV plazmaferezis állomás jelentette pozitív		
FC70	HCV konfirmált pozitív		
FC80	HCV kétes		
FC90	HCV technikai ok miatt nem meghatározható		
FE01	Élősdiek által okozott fertőzés		
FF01	Helminthiasis		
FG01	Fertőző eredetű hasmenés		
FH01	HIV konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FH02	HIV konfirmálás folyamatban	INAKT	##
FH03	AIDS / HIV diagnózis OVSz vizsg. nélkül (lásd FH13)	INAKT	###
FH06	Negatív HIV konfirmálást követő kizárás	INAKT	##
FH07	HIV szűrő reaktív, konfirmáltan negatív	INAKT	##
FH08	HIV reaktív, fertőzés nem konfirmálható	INAKT	##
FH09	HIV visszahívás eredménytelen	INAKT	##
FH11	HIV véradási minta pozitív	INAKT	##
FH12	HIV fertőzés korai stádiumának gyanúja	INAKT	##
FH13	AIDS / HIV OVSz vizsgálat nélkül pozitív		
FH18	HIV véradási minta kétes	INAKT	##
FH21	HIV véradási minta NAT reaktív	INAKT	##
FH30	HIV konfirmálás folyamatban		
FH31	HIV véradási minta konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FH33	AIDS / HIV diagnózis OVSz vizsg. nélkül	INAKT	###
FH39	HIV kétes második mintára vár	INAKT	##
FH40	HIV konfirmálás második mintára vár	INAKT	##
FH41	HIV két mintából konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FH42	HIV konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	INAKT	##
FH43	HIV reaktív, fertőzés nem konfirmálható	INAKT	##
FH47	HIV konfrimált negatív		
FH48	HIV nem igazolt szűrő reaktivitás		
FH51	HIV visszavezetés		
FH60	HIV plazmaferezis állomás jelentette pozitív		
FH70	HIV pozitív		
FH80	HIV kétes		
FH90	HIV technikai ok miatt nem meghatározható		
FI01	Creutzfeldt-Jakob betegség és vCJD		
FI02	Veszettség		
FI03	A központi idegrendszer egyéb vírusai		
FK01	Bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés	INAKT	#
FK02	Felnőttkori gyermekbetegségek		
FK03	Ajak és genitális herpesz		
FK04	Szemölcs		
FK05	Bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó egyéb vírusfertőzés		
FL01	Lepra		
FM01	Mycosis		
FN01	Nemi betegség		
FO01	Lyme-kór (borreliosis) diagnózis		
FP01	Malária		
FP02	Leishmaniasis (Kala-azar)		
FP03	Chagas-betegség (tripanosomiasis)		
FP04	Toxoplasmosis		
FP05	Babesiosis		
FQ02	Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak	INAKT	#
FQ03	Dengue láz		
FQ04	Chikungunya vírus betegség		
FQ05	O' nyong-nyong láz		
FQ06	Venezuelai ló-láz		
FQ07	Nyugat Nílusi láz (WNV)		
FQ08	Zika vírus betegség		
FQ09	Rift Valley láz		
FQ10	Sárgaláz		
FQ11	Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz külön megnevezés nélkül	INAKT	#
FQ12	Vírusos hemorrhagias láz k.m.n.	INAKT	#
FQ21	WNV NAT pozitív		
FQ22	Zika vírus véradási minta NAT reaktív	INAKT	###
FR01	Q-láz		
FS01	Syphilis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FS02	anti-TP konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FS03	anti-TP konfirmálás folyamatban	INAKT	##
FT01	Légzőszervi gümőkór		
FT02	Egyéb szervek gümőkórja		
FV01	Mononucleosis infectiosa		
FV02	HTLV I/II pozitivitás		
FV03	Parvovirus B19		
FV04	Mumpsz	INAKT	#
FV21	Parvo B19 NAT pozitív	INAKT	##
FV70	Parvo B19 NAT pozitív		
FW01	anti-TP konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FW02	anti-TP konfirmálás folyamatban	INAKT	##
FW03	Syphilis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FW05	anti-TP szűrővizsgálat ismételten reaktív	INAKT	##
FW06	Negatív anti-TP konfirmálást követő kizárás	INAKT	##
FW08	anti-TP reaktív, fertőzés nem konfirmálható	INAKT	##
FW09	anti-TP visszahívás eredménytelen	INAKT	##
FW12	VDRL pozitív	INAKT	##
FW13	Syphilis OVSz vizsgálat nélkül pozitív		
FW30	anti-TP konfirmálás folyamatban		
FW31	anti-TP véradási minta konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FW33	anti-TP diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FW35	VDRL véradási minta pozitív	INAKT	##
FW39	anti-TP kétes második mintára vár	INAKT	##
FW40	anti-TP konfirmálás második mintára vár	INAKT	##
FW41	anti-TP két mintából konfirmáltan pozitív	INAKT	##
FW42	anti-TP konfirmáltan negatív, szűrő reaktív	INAKT	##
FW43	anti-TP reaktív, fertőzés nem konfirmálható	INAKT	##
FW45	VDRL második minta pozitív	INAKT	##
FW47	anti-TP konfirmált negatív		
FW48	anti-TP- nem igazolt szűrő reaktivitás		
FW51	anti-TP visszavezetés	INAKT	##
FW70	anti-TP pozitív		
FW80	anti-TP kétes RPR negatív	INAKT	##
FW81	anti-TP kétes, RPR pozitív	INAKT	##
FW82	anti-TP kétes		
FW90	anti-TP technikai ok miatt nem meghatározható		
FX51	Egyéb fertőző betegség visszavezetés		
FX99	Egyéb fertőző betegség		
FY01	Hepatitis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FY13	Hepatitis OVSz vizsgálat nélkül pozitív		
FY14	HEV diagnózis OVSz vizsgálat nélkül		
FY33	Hepatitis diagnózis OVSz vizsgálat nélkül	INAKT	###
FZ01	Brucellosis		
FZ02	Egyéb bakteriális zoonosis		
KH01	Sugárbetegség		
KH02	Napszúrás, egyéb hő és fényhatások		
KM01	Mérgezéses állapot vagy annak gyanúja		
KS01	Felületes sérülés		
KS02	Csonttörés		
KS03	Ficam		
KS04	Égés, maródás, áramütés		
RA01	Terhesség, szülés megszakadt terhesség		
RA02	Szülés	INAKT	#
RA03	Abortus	INAKT	#
RA04	Menstruáció	INAKT	#
RA05	Anamnézisben anafilaxia vagy nagyfokú túlérzékenység		
RA06	Nagyfokú mozgáskorlátozottság		
RA07	Felső végtag hiánya		
RA08	Belső szerv hiánya vagy részleges elvesztése (korábban lép szerzett hiánya)		
RA09	Hypotenzív szövődmény az anamnézisben		
RA10	Véralvadásgátló gyógyszer szedése		
RA11	Teratogén kockázatú gyógyszer szedése		
RA12	Nagy műtéti beavatkozás		
RA13	Szívműtét		
RA14	Műtéti beavatkozás		
RA15	Kisebb fogászati kezelés		
RA16	Foghúzás, gyökérkezelés		
RA17	Szervátültetésen esett át		
RA18	Sikertelen retranszfúzió		
RA19	Gyógyult in situ daganat	INAKT	#
RA20	Véradó nyilatkozata alapján (meg nem nevezett kockázati tényező)		
RA21	Sikertelen vérvétel		
RA22	Aktivált őssejtdonor		
RA23	Őssejt donációt követően		
RA24	Plazmaferezis nem OVSz intézetben	INAKT	#
RA25	Orvosi kivizsgálás		
RA26	Kontrasztanyaggal végzett vizsgálat		
RA27	BactAllert riasztás		
RA28	Véradó PDI bejelentése betegségről k.m.n.		
RF01	Vérrel átvihető fertőzések megszerzésének fokozott kockázata		
RF02	Állatharapás veszettség, vagy egyéb fertőzés fokozott kockázatával		
RF03	Intravénás kábítószer, vagy recept nélküli injekció használata		

RF04	Fertőző beteggel közös háztartásban él		
RF05	Trópusi betegség átvitelének kockázata		
RF05	Malária átvitelének kockázata		
RF06	Trópusi betegség átvitelének kiemelt kockázata		
RF07	Epidemiológiai kockázat miatt		
RF08	Kullancscsípést követően		
RF09	TSE kockázat		
RF10	Nem igazoltan steril tűvel kezelték		
RF11	Attenuált oltóanyagot kapott		
RF12	Állati szérumot kapott		
RF13	Transzfúziót kapott		
RF14	Stabil vérkészítményt kapott		
RF15	Xenotranszplantátum recipiens		
RF16	Iatrogén fertőzés kockázata		
RF17	Irregulária antitest (gyanú)	INAKT	#
RF18	Irregulária antitest (igazolt)	INAKT	#
RF19	DAT pozitivitás (3+, 4+)		
RF20	DAT ismételt pozitivitás	INAKT	#
RF21	RhD antigén PCR vizsgálatra vár	INAKT	#
RF22	Nemi átalakító műtéten esett át	INAKT	###
RF23	Huzamosan az Egyesült Királyságban élt.		
RF24	HBV elleni védőoltást kapott		
RF25	Expozíciót követő Hepatitis B immunglobulin prevenció		
RF26	MSM kapcsolat *Az RF26 kiszűrést le kell zárni. (Törölni tilos.)* *Ezek után, a kivizsgáló megítélése szerint:* *a kockázatos személyeket RF01 vagy RF28 kóddal kell szűrni*	INAKT	#
RF27	Az Egyesült Királyságban transzfúziót kapott		
RF28	Kockázatos szexuális életvitel		
RF29	COVID-19 karantén megfigyelés bejelentése	INAKT	#
RF30	COVID-19 fertőzés kockázat	INAKT	#
RF31	Vércsoport nem meghatározható rutin vércsoport-szerológiai módszerrel		
RF32	Külföldi első véradó (V előzetes mintavétel)		
RF33	DAT pozitivitás (1+ és 2+)		
RF34	Születéskori német okmányaiban megváltoztatták		
RF35	Malária hordozásának kockázata		
RF36	Chagas-betegség hordozásának kockázata		
RF37	Akupunktúrás kezelést kaptak.		
RF38	WNV kockázat miatt		
RF39	Dengue vírus kockázat miatt		
RF40	Chikungunya vírus kockázat miatt		
RF41	Zika vírus kockázat miatt lásd		
RF42	Kontaktus ragályos beteggel		
RM01	Veszélyes foglalkozás, vagy sport		
XX00	Egyéb kiszűrési ok		
XX01	Véradó visszavezetés alatt	INAKT	##
XX02	Kizárás kedvezőtlen esemény miatt	INAKT	###
XX03	Kiszűrés aferezisből egyéb ok miatt		
XX04	Sikertelen behívás véradásra	INAKT	#
XX05	Megszakadt vérvételi eljárás	INAKT	#
XX06	Plazmaferezis állomás bejelentése alapján		
XX07	Passzívált véradó	INAKT	#
XX08	Ipari célú mintaadás felfüggesztve		
XX09	Trombocita-ferezisre átmenetileg alkalmatlan		
XX10	Informatikai rendezés alatt		
XX99	A véradó elhalálozott		
YY00	Nyomonkövetés miatt	INAKT	##